



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ASI0730

Aplicaciones Web

NRC

16712

Informe del Trabajo

Docente

Sanchez Seña, Alberto Wilmer

Equipo

CodeBrokers

Proyecto

VitaLkink

Código - Apellidos y Nombres

U22421631 - Osorio Ramírez, Eduardo Jesús

U202312348 - Said Conde, Yazid

U202317767 - Tello Quispe, Luis German

U202316466 - Rodriguez Gonzales, Leonel German

U20201b772 - Salon Puerta, Merly

Período 202620

septiembre 2026

Registro de Versiones del Informe

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación

Project Report Collaboration Insights

Contenido

Registro de Versiones del Informe	1
Registro de Versiones del Informe	1
Project Report Collaboration Insights	2
Student Outcome	6
Capítulo I: Introducción	7
1.1 Startup Profile	7
1.1.1 Descripción de la Startup	7
1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo	8
1.2 Solution Profile	9
1.2.1 Antecedentes y problemática	9
1.2.2 Lean UX Process	12
1.3 Segmentos objetivo	14
1. Adultos mayores y sus familias que requieren acompañamiento preventivo	14
2. Clínicas y hospitales	15
Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis	15
2.1. Competidores	15
2.1.1. Análisis competitivo	18
2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores	21
2.2. Entrevistas	22
2.2.1. Diseño de entrevistas	22
2.2.2. Registro de entrevistas	22
2.2.3. Análisis de entrevistas	27
Segmento Objetivo: Clínicas y hospitales	27
1. Rol Principal	27
2. Contexto	27
3. Problemas Comunes	28
4. Frecuencia de Seguimiento	28
5. Datos Deseados Automáticamente	28
6. Transparencia y Confianza	28
7. Registro de Acciones	28
8. Adopción de la Aplicación	28
Segmento Objetivo: Familiares y Adultos mayores	28
1. Rol Principal	28
2. Contexto	29
3. Problemas Comunes	29
4. Frecuencia de Contacto / Autocontrol	29
5. Datos Deseados Automáticamente	29
6. Transparencia y Privacidad	29
7. Registro de Acciones	29
8. Facilidad de Uso	29
9. Adopción de la Aplicación	29
2.3. Needfinding	30
2.3.1. User Personas	30
2.3.2. User Task Matrix	30
2.3.3. User Journey Mapping	33
2.3.4. Empathy Mapping	34
Síntesis del Needfinding	36
2.4. Big Picture Event Storming	37
2.5. Ubiquitous Language	37

3. Capítulo III: Requirements Specification	38
3.1. User Stories	38
3.2. Impact Mapping	45
3.3. Product Backlog	46
4. Capítulo IV: Product Design	50
4.1. Style Guidelines	50
4.1.1. General Style Guidelines	50
Paleta de Colores y Jerarquía Visual	51
Spacing	52
Tono de Comunicación	52
4.1.2. Web Style Guidelines	53
Botones y Elementos de Acción	53
Enlaces de Navegación	53
Header	53
Estructura de las Secciones	54
Tarjetas y Contenedores	54
Tipografía	54
Iconografía	54
Elementos Visuales e Imágenes	54
Alertas y Estados	55
Paleta de Colores Común	55
Espaciado y Bordes	55
Diseño Responsivo	55
Tono Comunicacional General	55
4.2. Information Architecture	56
4.2.1. Organization Systems	56
Organización Jerárquica (Visual Hierarchy)	56
Organización Secuencial (Step-by-Step)	56
Organización por Secciones	56
Categorización por Tópicos	56
Categorización por Audiencia	57
4.2.2. Labeling Systems	57
Principios de Etiquetado	57
Categorías de Etiquetas	57
Etiquetas para Identificación de Audiencia	57
Etiquetas para Secciones Informativas	57
Etiquetas para Características y Beneficios	58
Etiquetas de Acción (Call-to-Action)	58
Etiquetas para Información Institucional	58
Asociaciones entre Etiquetas	58
4.2.3. SEO Tags and Meta Tags	58
SEO Tags y Meta Tags	58
Landing Page (Sitio Web Estático)	58
Tags principales	59
Tags de viewport y responsividad	59
Open Graph y Social Media Tags	59
Optimización de la Estructura de la Landing Page	59
Web Application	60
Tags principales	60
4.2.4. Searching Systems	60
4.2.5. Navigation Systems	60
4.3. Landing Page UI Design	61
4.3.1. Landing Page Wireframe	61

4.3.2. Landing Page Mock-up	66
4.4 Web Applications UX/UI Design	72
4.4.1. Web Applications Wireframes	72
4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams	79
4.4.3 .Web Applications Mock-ups	79
4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams	87
4.5. Web Applications Prototyping	88
4.6. Domain-Driven Software Architecture	88
4.6.1. Design-Level Event Storming	88
4.6.2. Software Architecture Context Diagram	88
4.6.3. Software Architecture Container Diagrams	88
4.6.4. Software Architecture Component Diagrams	88
4.7. Software Object-Oriented Design*	88
4.7.1. Class Diagrams	88
4.8. Database Design	88
4.8.1. Database Diagrams	88
Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment	88
5.1. Software Configuration Management	88
5.1.1. Software Development Environment Configuration	88
5.1.2. Source Code Management	88
5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions	88
5.1.4. Software Deployment Configuration	88
5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation	88
5.2.1. Sprint 1	88
5.2.2. Sprint 2	89
5.2.3. Sprint 3	89
5.2.4. Sprint 4	89
5.3. Validation Interviews.	90
5.3.1. Diseño de Entrevistas.	90
5.3.2. Registro de Entrevistas.	90
5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.	90
5.4. Video About the product	90
6. Conclusiones	90
6.1 Conclusiones y recomendaciones	90
6.2. Video about the team	90
7. Bibliografia	90
8. Anexos	90

Student Outcome

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.		

Capítulo I: Introducción

1.1 Startup Profile

1.1.1 Descripción de la Startup

Como startup, tenemos el compromiso de contribuir al cuidado y bienestar de los adultos mayores. Por ello, desarrollamos VitaLink, una plataforma digital orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores, cuyo objetivo es conectar, dentro de un mismo ecosistema, a los adultos mayores, sus familiares y diferentes proveedores de servicios de salud.

VitaLink permite centralizar información relacionada con el estado del adulto mayor y generar alertas cuando se identifican valores o combinaciones de datos que podrían representar una situación de riesgo. Estas alertas pueden ser comunicadas a los familiares autorizados y, dependiendo de la situación, a una institución de salud registrada en la plataforma.

De esta manera, CodeBrokers busca desarrollar tecnología que no solo permita monitorear información, sino que también facilite una respuesta oportuna y coordinada ante posibles situaciones de riesgo, contribuyendo a mejorar el acompañamiento y la seguridad de los adultos mayores.

Misión

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida y la seguridad de los adultos mayores mediante VitaLink, proporcionando herramientas digitales de monitoreo preventivo que permitan detectar oportunamente posibles situaciones de riesgo, facilitar la comunicación con sus familiares y conectar de manera eficiente con proveedores de servicios de salud.

Buscamos utilizar la tecnología como una herramienta de prevención y acompañamiento, facilitando que las personas responsables del cuidado puedan contar con información oportuna para tomar decisiones y actuar ante posibles situaciones de riesgo.

Visión

Nuestra visión es convertir a VitaLink, en una startup referente en Latinoamérica en el desarrollo de soluciones digitales para el monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores.

Buscamos construir un ecosistema en el que adultos mayores, familiares, clínicas, hospitales y profesionales de la salud puedan mantenerse conectados, favoreciendo una atención más preventiva, rápida, accesible y centrada en la persona.

A largo plazo, VitaLink podrá evolucionar mediante la integración con dispositivos inteligentes y otras tecnologías aplicadas al cuidado de la salud, permitiendo obtener información de manera más continua y automatizada. De esta forma, aspiramos a contribuir a la transición de un modelo de cuidado principalmente reactivo hacia uno preventivo, conectado y basado en información, donde la tecnología permita anticiparse a posibles situaciones de riesgo y facilitar una atención oportuna.

1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo

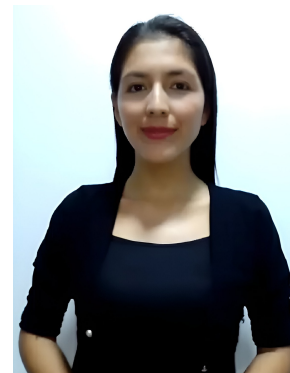
Integrante 1: Merly Salón Puerta

Código de estudiante: u20201b772

Carrera: Ingeniería de Software

Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, con interés en el desarrollo de soluciones tecnológicas, análisis de datos y aplicación de tecnologías emergentes para resolver problemas reales.

Aporte al equipo: Participación en el análisis y desarrollo de la solución, organización de actividades, elaboración de documentación y apoyo en la implementación y validación del proyecto.



Integrante 2: Yazid Said Conde

Código de estudiante: u202312348

Carrera: Ingeniería de Software

Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, trabajador y comprometido con su aprendizaje. Tiene interés en aprender constantemente, especialmente en áreas relacionadas con la tecnología, y cuenta con conocimientos en HTML, CSS, JavaScript, Python, C++ y SQL.

Aporte al equipo: Contribución al desarrollo del proyecto mediante sus conocimientos en programación y tecnologías web, participando en la implementación de funcionalidades, resolución de problemas técnicos y trabajo colaborativo.



Integrante 1: Eduardo Osorio Ramírez

Código de estudiante: U202421631

Carrera: Ingeniería de Software

Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, comprometido a ampliar sus conocimientos de programación y a aportar activamente al desarrollo del proyecto. Posee experiencia en C, C++, HTML y CSS.

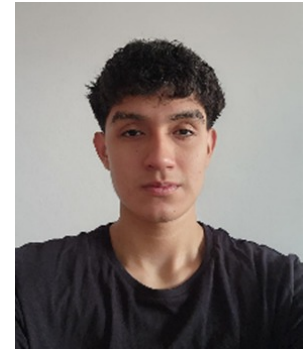
Aporte al equipo: Aporte al desarrollo del proyecto, mediante la resolución de documentos y aplicación de lenguajes de programación, así como la organización y revisión de los entregables.



Integrante 4: Leonel German Rodriguez Gonzales**Código de estudiante:** U202316466**Carrera:** Ingeniería de Software

Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, interesado en seguir desarrollando sus conocimientos en programación, análisis de datos y desarrollo de soluciones tecnológicas. Cuenta con conocimientos en Python, SQL, C++, Power BI y está en constante aprendizaje de nuevas herramientas y tecnologías.

Aporte al equipo: Contribución al desarrollo del proyecto mediante la elaboración y organización de documentación, participación en el análisis de la solución y apoyo al equipo aplicando sus conocimientos en programación y manejo de datos.

**Integrante 1: Luis German Tello Quispe****Código de estudiante:** U202317767**Carrera:** Ingeniería de Software

Descripción: Soy un estudiante de la carrera de ing de software, me interesa mucho el lado del backend, tecnologías como python, mysql, mongodb, c++ y también me entusiasma en un futuro poder aprender mucho sobre ciberseguridad de la mano del backend.

Aporte al equipo: Apoyo a mi equipo con estructuración de los documentos para el desarrollo del proyecto. Además, apoyo mediante análisis de correcciones a lo largo del avance, en base a mis conocimientos tanto de programación como análisis de requerimientos y requisitos.

**Integrante: Harold Fauskorp Benigno Montero****Código de estudiante:** U202321086**Carrera:** Ingeniería de Software

Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, con conocimientos en git, GitHub, C++, HTML, CSS, JavaScript, POO, algoritmos y estructura de datos, modelamiento de bases de datos relacionales y no relacionales, MongoDB, y buen dominio de PostgreSQL y SQL Server.

Aporte al equipo: Apoyo a mi equipo con estructuración de los documentos para el desarrollo del proyecto. Asimismo, contribuyo con la revisión y corrección de los avances, apoyándome en mis conocimientos de programación y en el análisis de requerimientos y requisitos.



1.2 Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

Antecedentes El envejecimiento de la población representa un desafío cada vez más importante para los sistemas de salud y las familias. La Organización Mundial de la Salud señala que la población mundial de 60 años o más está aumentando rápidamente y estima que para 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. Este proceso genera nuevos desafíos para los sistemas de salud y asistencia social, especialmente en la atención y cuidado de las personas mayores (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2025).

Frente a esta realidad surge **VitaLink**, orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores. La plataforma busca centralizar información relevante, identificar posibles situaciones de riesgo y

facilitar la comunicación entre el adulto mayor, sus familiares y proveedores de atención.

Problemática Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran:

- **Falta de monitoreo continuo:** los familiares no siempre cuentan con información actualizada sobre el estado del adulto mayor.
- **Detección tardía de situaciones de riesgo:** determinados cambios en indicadores de salud pueden pasar desapercibidos hasta que la situación requiere atención.
- **Dificultad para reaccionar oportunamente ante incidentes:** ante una caída, alteración de signos vitales u otra situación de riesgo, puede existir un retraso en la comunicación con familiares o servicios de atención.
- **Información de salud dispersa:** los datos relacionados con el adulto mayor pueden encontrarse distribuidos entre familiares, documentos o diferentes proveedores de salud.
- **Falta de conexión entre familiares y proveedores de atención:** cuando ocurre una situación que requiere asistencia, no siempre existe un mecanismo centralizado que facilite el contacto con una institución o profesional disponible.
- **Dependencia de la supervisión presencial:** el acompañamiento puede depender de que un familiar o cuidador se encuentre físicamente cerca del adulto mayor.

Estas dificultades pueden generar preocupación en los familiares, retrasos en la atención y una mayor exposición del adulto mayor ante situaciones que podrían ser detectadas de manera temprana.

5W y 2H

What? (¿Cuál es el problema?) Los familiares y cuidadores de adultos mayores no siempre cuentan con una herramienta que les permita conocer oportunamente el estado de salud de la persona a su cargo y detectar posibles situaciones de riesgo cuando no se encuentran físicamente con ella.

Actualmente, el seguimiento suele depender de llamadas telefónicas, mensajes, visitas presenciales o de que el propio adulto mayor comunique que presenta algún problema. Esto puede generar detección tardía de situaciones de riesgo, especialmente cuando el adulto mayor vive solo, permanece varias horas sin compañía o presenta dificultades para comunicar oportunamente un cambio en su estado.

Además, la información relacionada con su salud puede encontrarse dispersa entre familiares, documentos o diferentes proveedores de atención, dificultando el seguimiento y la toma de decisiones.

When? (¿Cuándo sucede el problema?) El problema puede presentarse de manera recurrente durante las actividades cotidianas del adulto mayor, especialmente cuando los familiares o cuidadores no se encuentran cerca para supervisarlo.

La situación se vuelve más crítica cuando ocurre un evento inesperado, como una caída, una alteración de determinados indicadores de salud o cualquier otra condición que pueda representar un riesgo. En estos casos, el tiempo transcurrido entre la aparición del problema y la comunicación con un familiar o proveedor de atención puede ser determinante.

También se presenta cuando los familiares desean conocer el estado del adulto mayor, pero no cuentan con información actualizada y deben depender de una comunicación manual para obtenerla.

Where? (¿Dónde ocurre el problema?) El problema se presenta principalmente en hogares y entornos donde los adultos mayores desarrollan sus actividades cotidianas, especialmente cuando permanecen solos o tienen un nivel reducido de supervisión presencial.

En el contexto inicial de VitaLink, la problemática se plantea principalmente en **Lima Metropolitana** y otras ciudades del Perú, donde existe una creciente población adulta mayor y una necesidad de fortalecer los mecanismos de acompañamiento y prevención.

Asimismo, el problema involucra la relación entre los hogares de los adultos mayores y los establecimientos y profesionales de salud, debido a la dificultad de conectar oportunamente a ambas partes cuando se presenta una situación que requiere atención.

Why? (¿Por qué ocurre el problema?) El problema ocurre principalmente porque el acompañamiento de los adultos mayores continúa dependiendo, en gran medida, de la supervisión presencial y de mecanismos de comunicación manuales.

A pesar de la disponibilidad de tecnologías de monitoreo y dispositivos inteligentes, no siempre existe una plataforma accesible que integre la información del adulto mayor con un sistema de alertas y una red de familiares y proveedores de atención.

Además, la información puede encontrarse fragmentada y no necesariamente existe un mecanismo que permita detectar una posible situación de riesgo, notificarla a las personas responsables y facilitar el acceso a atención desde un mismo ecosistema.

Esta situación dificulta pasar de un modelo de atención principalmente reactivo a uno más preventivo y basado en información.

Who? (¿Quiénes están involucrados?)

- **Adultos mayores:** quienes son los principales beneficiarios de una solución que permita brindarles mayor seguridad y acompañamiento durante sus actividades cotidianas.
- **Familiares y cuidadores:** quienes tienen la responsabilidad de acompañar y supervisar al adulto mayor, pero pueden tener dificultades para hacerlo de manera permanente debido a sus actividades laborales, distancia geográfica u otras responsabilidades.
- **Clínicas y hospitales:** que pueden participar como proveedores de atención asociados al adulto mayor y recibir alertas cuando sea necesario gestionar una atención.

How? (¿Cómo se presenta el problema?) El proceso actual puede desarrollarse de la siguiente manera:

Adulto mayor presenta una situación de riesgo → no existe monitoreo o alerta automática → el familiar desconoce la situación → el problema continúa o se agrava → el adulto mayor o una tercera persona comunica el incidente → el familiar intenta determinar qué hacer → busca contactar a un establecimiento o profesional de salud → se inicia la gestión de atención.

Este proceso puede generar retrasos en la comunicación y en la respuesta, especialmente cuando el familiar se encuentra lejos o desconoce la gravedad de la situación.

En otros casos, el familiar puede realizar llamadas o comunicarse constantemente con el adulto mayor para verificar que se encuentre bien, lo que genera una dependencia de la supervisión manual.

How much? (¿Qué tan severo es el problema?) La severidad del problema no se limita a un costo económico directo, sino que está relacionada principalmente con el tiempo de respuesta, la seguridad del adulto mayor y la tranquilidad de sus familiares.

Por ello, el impacto del problema puede observarse en tres dimensiones principales:

- **Seguridad:** una situación de riesgo podría no ser detectada oportunamente.
- **Tiempo:** puede existir un retraso entre la aparición del problema y la comunicación con familiares o proveedores de atención.
- **Tranquilidad familiar:** los familiares no cuentan siempre con información suficiente para saber si el adulto mayor se encuentra bien.

1.2.2 Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements Problem Statement 1: Monitoreo Preventivo y Seguridad del Adulto Mayor La seguridad y el bienestar del adulto mayor se ven comprometidos debido a la ausencia de un sistema digital que permita un monitoreo continuo y la detección oportuna de situaciones de riesgo cuando no se encuentra acompañado. Actualmente el acompañamiento depende en gran medida de la supervisión presencial y de comunicaciones manuales (llamadas, mensajes o visitas), lo que puede provocar que una caída, una alteración de signos vitales u otra situación de riesgo pase desapercibida hasta que el problema se agrava. ¿Cómo podemos diseñar una solución tecnológica que permita monitorear de forma preventiva el estado del adulto mayor y generar alertas oportunas ante posibles situaciones de riesgo?

Problem Statement 2: Comunicación y Conexión entre Familiares y Proveedores de Salud La tranquilidad y capacidad de respuesta de los familiares y cuidadores se ven limitadas debido a la falta de un canal centralizado que conecte al adulto mayor, su red familiar y los proveedores de atención en salud. La información relacionada con la salud del adulto mayor suele encontrarse dispersa entre familiares, documentos y distintos proveedores, lo que dificulta el seguimiento y retrasa la toma de decisiones ante un incidente. Esta dispersión, sumada a la falta de un mecanismo de contacto inmediato con clínicas y hospitales genera demoras entre la aparición de una situación de riesgo y el inicio de la atención correspondiente. ¿Cómo podemos diseñar una plataforma que centralice la información de salud del adulto mayor y facilite una comunicación eficiente entre familiares, cuidadores y proveedores de servicios de salud?

1.2.2.2. Lean UX Assumptions Los siguientes supuestos establecen las creencias iniciales del equipo sobre los factores que influenciarán en el éxito de VitaLink.

Business Outcomes (Resultados de Negocio) Reducir el tiempo de respuesta ante situaciones de riesgo detectadas al contar con un sistema de alertas que sustituya la dependencia de la supervisión presencial constante. Incrementar la adopción de mecanismos de monitoreo preventivo entre familias con adultos mayores durante los primeros meses de operación dado que actualmente el seguimiento depende de mecanismos manuales e informales. Consolidar alianzas con clínicas, hospitales y profesionales de salud que se integren como proveedores de atención dentro del ecosistema, mejorando la eficiencia en la gestión de incidentes.

User & User Outcomes (Usuarios y Resultados esperados) Adultos mayores contarán con mayor seguridad y acompañamiento durante sus actividades cotidianas incluso cuando no estén acompañados físicamente. Familiares y cuidadores podrán acceder a información oportuna sobre el estado del adulto mayor y actuar con rapidez ante una alerta, reduciendo la incertidumbre y la dependencia de la comunicación manual. Clínicas y hospitales podrán recibir alertas y datos relevantes de manera oportuna facilitando una gestión de atención más ágil y mejor informada.

Features (Características de la solución) Las propuestas de VitaLink se sustentan en las siguientes funciones: Monitoreo preventivo: Seguimiento de indicadores relevantes del adulto mayor para identificar posibles situaciones de riesgo de manera temprana. Sistema de alertas: Notificaciones automáticas a familiares y/o proveedores de salud ante la detección de una situación que requiera atención. Centralización de información: Un espacio único donde se consolide la información de salud del adulto mayor, actualmente dispersa entre distintos actores. Canal de comunicación familiar-proveedor: Mecanismo que conecte de forma directa y eficiente a los familiares con clínicas, hospitales o profesionales de salud disponibles. Panel de seguimiento: Interfaz que permita a los familiares y/o cuidadores visualizar el estado general del adulto mayor de forma remota.

Risk & Assumptions (Riesgos y Supuestos)

Supuesto 1: Los familiares adoptarán la aplicación si perciben que reduce de forma significativa su incertidumbre respecto al bienestar del adulto mayor.

Supuesto 2: Los adultos mayores aceptarán el uso de herramientas digitales de monitoreo si la interfaz es simple y accesible.

Supuesto 3: Las clinicas y hospitales estaran dispuestos a integrarse dentro del ecosistema si el sistema de alertas es confiable y reduce tiempos de gestion.

Supuesto 4: La centralizacion de la informacion de salud permitira anticipar situaciones de riesgo que hoy pasan desapercibidas por la dispersion de datos entre distintos actores.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- **Declaracion de Hipotesis 1:**

- **Creemos que lograremos** una mayor adopcion del monitoreo preventivo y una reduccion de situaciones de riesgo detectadas tardíamente
- **Si** los familiares y cuidadores responsables de adultos mayores
- **Obtienen** acceso continuo a informacion relevante sobre el estado del adulto mayor, incluso cuando no se encuentran fisicamente con el
- **Con** una funcionalidad de monitoreo preventivo que permita realizar el seguimiento de indicadores relevantes e identificar posibles situaciones de riesgo.

- **Declaracion de Hipotesis 2:**

- **Creemos que lograremos** reducir el tiempo de respuesta ante posibles situaciones de riesgo
- **Si** los familiares, cuidadores y proveedores de atencion
- **Obtienen** informacion oportuna sobre una situacion que pueda requerir su intervencion
- **Con** un sistema de alertas automaticas que notifique a los responsables cuando se detecte una posible situacion de riesgo.

- **Declaracion de Hipotesis 3:**

- **Creemos que lograremos** mejorar el seguimiento del estado del adulto mayor y facilitar el acceso a información para la toma de decisiones
- **Si** los familiares, cuidadores y proveedores de atencion
- **Obtienen** acceso organizado a la informacion relevante del adulto mayor desde un unico lugar
- **Con** una funcionalidad que centralice la informacion que actualmente se encuentra distribuida entre diferentes actores.

- **Declaracion de Hipotesis 4:**

- **Creemos que lograremos** reducir el tiempo necesario para establecer contacto con un proveedor de atencion ante una situacion que requiera asistencia
- **Si** los familiares y cuidadores responsables del adulto mayor
- **Obtienen** una forma directa de comunicarse con clinicas, hospitales o profesionales disponibles
- **Con** un canal de comunicacion que conecte a los familiares con los proveedores de atencion integrados en la plataforma.

- **Declaracion de Hipotesis 5:**

- **Creemos que lograremos** incrementar la frecuencia de uso de la plataforma por parte de familiares y cuidadores
- **Si** los familiares y cuidadores
- **Obtienen** una vision clara y rapida del estado general del adulto mayor sin necesidad de encontrarse fisicamente con el
- **Con** un panel de seguimiento que presente de manera accesible la informacion relevante sobre su estado.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1. Business Problem	2. Business Outcomes	3. Users
El cuidado de adultos mayores depende de registros manuales y respuestas reactivas ante emergencias de salud, generando demoras críticas y desconexión entre el monitoreo diario del hogar y los centros de atención médica.	- Reducción del 50% en el tiempo para coordinar una cita ante anomalías. - Tasa mínima del 70% de aceptación en citas pre-agendadas. - Afiliación de al menos 15 centros de salud a la red. - Incremento del 30% en la retención mensual de familias suscriptoras.	- Cuidadores familiares principales (hijos, tutores). - Adultos mayores con enfermedades crónicas. - Centros de salud y profesionales médicos independientes.

4. User Outcomes & Benefits	5. Solutions	6. Hypotheses
- Detección temprana de anomalías biométricas y tranquilidad familiar continua. - Atención médica rápida sin búsqueda manual de proveedores en crisis. - Historial clínico y triaje previo disponible para el médico antes de la consulta. - Acceso a consultas a tarifa social para adultos mayores sin seguro.	- Plataforma SaaS con tablero de telemetría IoT simulada en tiempo real. - Sistema inteligente de triaje y pre-agendamiento automático de consultas. - Historial biométrico centralizado y ficha de triaje exportable. - Módulo de atención a tarifa social conectado con policlínicos y ONGs. - Notificaciones automatizadas vía SMS y mensajería de emergencia.	- Creemos que el monitoreo IoT en tiempo real logrará un 30% más de retención mensual al brindar tranquilidad continua a los cuidadores. - Creemos que el auto-agendamiento inteligente reducirá en 50% el tiempo de coordinación de citas de urgencia. - Creemos que el historial y triaje previo aumentará un 40% los convenios con clínicas. - Creemos que las alertas SMS lograrán un 75% de confirmación en los primeros 5 minutos. - Creemos que la tarifa social logrará un 35% de adopción en hogares sin seguro privado.

7. What is the most important thing we need to learn first?	8. What is the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?
- Validar si los cuidadores familiares aceptan y confían en el auto-agendamiento ante una anomalía detectada. - Confirmar la disposición de las clínicas para publicar y gestionar sus cupos de atención dentro del SaaS. - Identificar el rango de precio mensual aceptable para los planes familiares de suscripción.	- Desplegar la Landing Page con la propuesta de valor y medir el interés de registro de cuidadores y clínicas. - Probar prototipos interactivos en Figma con cuidadores para validar el flujo de confirmación de citas en un clic. - Ejecutar simulaciones del flujo de datos IoT y pre-agendamiento en el MVP inicial.

1.3 Segmentos objetivo

1. Adultos mayores y sus familias que requieren acompañamiento preventivo

Este segmento está conformado por adultos mayores de 60 años y sus familiares, especialmente aquellos que desean mantener un sistema de acompañamiento y monitoreo preventivo para mejorar la seguridad del adulto mayor.

A diferencia del primer segmento, este grupo puede estar compuesto por familias en las que el propio adulto

mayor participa activamente en la decisión de utilizar VitaLink, por ejemplo, porque vive solo, pasa gran parte del día sin compañía o desea que sus familiares puedan conocer su estado sin necesidad de realizar llamadas constantes.

Características principales:

- **Adultos mayores de 60 años a más.**
 - **Pueden vivir solos, con familiares o con un cuidador.**
 - **Cuentan con uno o más familiares interesados en su bienestar.**
 - **Buscan mantener cierto nivel de independencia sin dejar de contar con acompañamiento.**
 - **Pueden estar asociados a una clínica, hospital o profesional de salud.**
 - **Tanto el adulto mayor como sus familiares pueden interactuar con la plataforma.**
-

2. Clínicas y hospitales

Este segmento representa a los proveedores de atención que forman parte del ecosistema de VitaLink.

Perfil:

- **Clínicas y hospitales privados.**
- **Centros de atención interesados en servicios digitales.**
- **Médicos independientes.**
- **Profesionales que ofrecen atención a domicilio.**

Necesidad: Recibir solicitudes de atención de potenciales pacientes y contar con un canal digital para gestionar dichas solicitudes.

Qué les ofrece VitaLink:

- **Acceso a potenciales pacientes.**
- **Recepción de alertas o solicitudes de atención.**
- **Mayor visibilidad de las necesidades de los usuarios.**
- **Gestión de solicitudes desde la plataforma.**
- **Posibilidad de ampliar sus servicios mediante atención conectada digitalmente.**

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

Para el análisis de competidores se priorizó la identificación de soluciones digitales con un modelo de negocio similar al de VitaLink: aplicaciones orientadas al monitoreo remoto de adultos mayores y a la conexión entre el adulto mayor, sus familiares/cuidadores y, en algunos casos, proveedores de atención. Dado que en el mercado peruano no se identificaron startups comerciales activas con una oferta equivalente (solo iniciativas académicas no comercializadas), se consideraron competidores directos de alcance internacional/regional, cuya propuesta de valor es comparable a la de VitaLink.

Los competidores identificados son:

1. **cuYdo** (España) — aplicación móvil que, mediante sensores instalados en el hogar, permite a familiares y cuidadores conocer en tiempo real la situación del adulto mayor que vive solo, sin uso de cámaras.



2. **CuidApp** (Argentina) — aplicación orientada a coordinar el cuidado de un adulto mayor entre un “cuidador principal” y un grupo de “ayudantes” (familiares/cuidadores secundarios).



3. **Silver-Digi** (España) — aplicación que facilita la independencia de adultos mayores mediante videollamadas automáticas con cuidadores/familiares y monitoreo remoto de datos de sensores.



2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape

¿Por qué llevar a cabo este análisis? Conocer cómo VitaLink se posiciona frente a soluciones existentes de monitoreo y acompañamiento de adultos mayores, en términos de propuesta de valor, alcance funcional y modelo comercial, para reforzar su ventaja competitiva.

Grupo	Aspecto	VitaLink	cuYdo	CuidApp	Silver-Digi
Perfil	Overview	Plataforma de CodeBrokers que centraliza el estado de salud del adulto mayor y conecta a familiares y proveedores de salud mediante alertas preventivas.	App para familiares de adultos mayores que viven solos, basada en sensores de movimiento en el hogar que aprenden rutinas y detectan posibles riesgos. Para el funcionamiento de cuYdo se realiza una sencilla instalación de sensores inalámbricos que se pegan en las principales estancias de la vivienda de la persona mayor, con estos sensores cuYdo aprende los hábitos y rutinas de cada persona mayor, a partir de los cuales determina cuándo se produce una situación de posible peligro.	App de coordinación del cuidado, organizada en torno a un cuidador principal (administrador) y un grupo de cuidadores secundarios (ayudantes) con acceso a la información del adulto mayor. La App está pensada para la persona que tiene a su cargo el cuidado de un adulto mayor, que será el Administrador de la aplicación, llamado "Cuidador principal", y otros usuarios habilitados por el Administrador, llamados "Ayudantes", que pasan a formar parte del "Grupo de cuidadores".	App que promueve la independencia de adultos mayores de 65+ mediante videollamadas automáticas y monitoreo remoto de sensores para cuidadores y familiares. Silver-Digi está diseñada para promover la independencia y el bienestar de las personas mayores de 65 años, facilitando la conexión con cuidadores profesionales y familiares mediante videollamadas automáticas y monitorización remota de datos de sensores.
Perfil	Ventaja competitiva	Integra en un mismo ecosistema al adulto mayor, la red familiar y proveedores de salud (clínicas/hospitales), no solo el entorno familiar.	Detección de patrones de riesgo sin cámaras, preservando la privacidad del adulto mayor.	Estructura simple de roles (principal/ayudantes) que facilita la coordinación entre varios cuidadores.	Interacción por videollamada automática, pensada para adultos mayores con baja alfabetización digital.

Grupo	Aspecto	VitaLink	cuYdo	CuidApp	Silver-Digi
Perfil	¿Qué valor ofrece a los clientes?	Tranquilidad familiar, detección temprana de riesgos y canal directo con proveedores de salud.	Tranquilidad sobre la seguridad del adulto mayor en su propio hogar.	Organización y reparto de responsabilidades de cuidado entre varios familiares.	Compañía, supervisión remota y reducción de la brecha digital para el adulto mayor.
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	Familias con adultos mayores de 60+ en Lima Metropolitana y ciudades del Perú; clínicas y hospitales.	Familiares de adultos mayores que viven solos (España/Europa).	Familias con más de un cuidador involucrado (Argentina/Latinoamérica).	Adultos mayores 65+ y sus cuidadores/familiares (España).
Perfil de Marketing	Estrategias de marketing	Landing page con call-to-action segmentado (familiares vs. proveedores de salud), alianzas con clínicas.	Difusión a través de fundaciones y programas de buenas prácticas en cuidado de mayores.	Distribución vía tiendas de aplicaciones (Google Play / App Store).	Distribución vía App Store, enfocada en accesibilidad y facilidad de uso.
Perfil de Producto	Productos & Servicios	App web/móvil de monitoreo preventivo, sistema de alertas, panel de seguimiento, canal de comunicación con proveedores.	App móvil + kit de sensores para el hogar.	App móvil de coordinación de cuidados y grupo de cuidadores.	App (solo iOS) + tablet con descuelgue automático para videollamadas.
Perfil de Producto	Precios & Costos	Modelo a definir (freemium para familiares, planes para clínicas).	No publica precios de forma abierta; requiere instalación de hardware.	Información no publicada públicamente.	Aplicación gratuita; costo de la tablet/hardware no publicado.
Perfil de Producto	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Landing Page + Web Application (responsive).	Aplicación móvil (Android/iOS).	Aplicación móvil (Android/iOS).	Aplicación móvil (solo iOS).

Análisis SWOT

Categoría	VitaLink	cuYdo	CuidApp	Silver-Digi
Fortalezas	Integra familiares y proveedores de salud en un mismo ecosistema; enfoque preventivo con sistema de alertas automáticas.	Detección de riesgos sin cámaras, preservando la privacidad del adulto mayor.	Modelo simple de roles entre cuidadores (principal/ayudantes).	Interfaz pensada para reducir la brecha digital del adulto mayor.
Debilidades	Producto aún en fase de validación, sin usuarios reales ni alianzas confirmadas con clínicas u hospitales.	Depende de instalación física de sensores en el hogar.	No incorpora un sistema de alertas ni conexión con proveedores de salud.	Disponible solo para iOS, lo que limita su alcance.
Oportunidades	Crecimiento acelerado de la población adulta mayor en el Perú; ausencia de un competidor local consolidado.	Expansión a mercados latinoamericanos.	Alta necesidad de coordinación familiar en el cuidado del adulto mayor.	Interés creciente en soluciones de acompañamiento remoto por videollamada.
Amenazas	Adopción tecnológica limitada en adultos mayores; ingreso de competidores internacionales (cuYdo, Silver-Digi) al mercado peruano.	Soluciones basadas solo en software (como VitaLink), sin hardware, con menor fricción de adopción.	Plataformas con enfoque preventivo/predictivo (como VitaLink) que ofrecen mayor valor agregado.	Soluciones multiplataforma y con mayor cobertura funcional (alertas + panel + proveedores de salud).

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Con base en el análisis competitivo anterior, CodeBrokers adoptará las siguientes estrategias y tácticas preliminares para VitaLink:

- **Frente a la falta de conexión con proveedores de salud (debilidad común en cuYdo, CuidApp y Silver-Digi):** posicionar como diferenciador principal el canal de comunicación directo entre familiares y clínicas/hospitales, resaltándolo en la Landing Page y en el flujo de onboarding.
- **Frente a la dependencia de hardware de cuYdo:** comunicar que VitaLink no requiere instalación de sensores físicos, reduciendo la fricción de adopción y el costo inicial para las familias.
- **Frente a la limitación de plataforma de Silver-Digi (solo iOS):** desarrollar la Web Application con diseño responsive, accesible desde cualquier dispositivo, ampliando el alcance a segmentos con menor poder adquisitivo.
- **Frente a la baja adopción tecnológica en adultos mayores (amenaza para todo el mercado):** diseñar una interfaz simple e inclusiva (a11y) dirigida principalmente a familiares/cuidadores como usuarios primarios, sin exigir que el adulto mayor interactúe directamente con la plataforma.
- **Frente al posible ingreso de competidores internacionales al mercado peruano (amenaza):** priorizar alianzas tempranas con clínicas y hospitales locales como barrera de entrada, aprovechando que VitaLink nace con enfoque en el ecosistema de salud peruano.
- **Aprovechando la ausencia de un competidor local consolidado (oportunidad):** enfocar la estrate-

gia de marketing inicial en Lima Metropolitana, apoyándose en el crecimiento de la población adulta mayor en el país.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Segmento 1: Clínicas y Hospitales

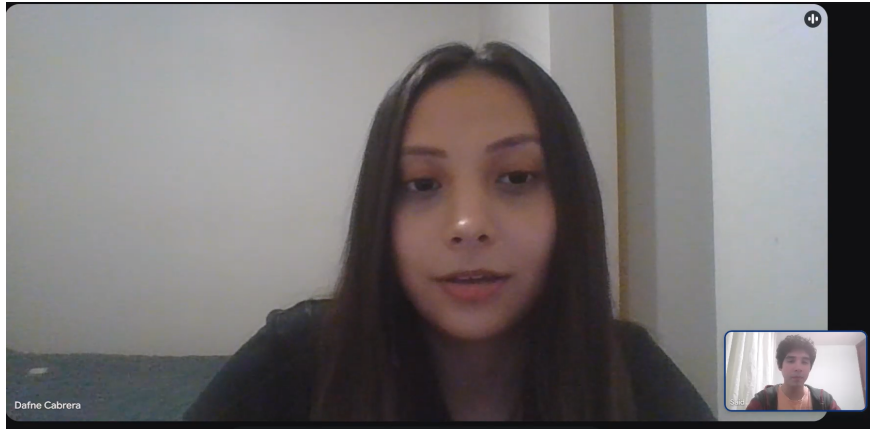
1. ¿Cómo hace usted actualmente el seguimiento de sus pacientes adultos mayores fuera de la consulta?
2. ¿Qué dificultades enfrenta para mantenerse informado sobre el estado de un paciente entre visita y visita?
3. Cuando algo anormal ocurre con un paciente, ¿cómo se entera usted normalmente?
4. ¿Qué tan rápido logra usted enterarse de una situación que requiere su atención, con el método que usa hoy?
5. ¿Qué información necesita revisar primero cuando le avisan que un paciente tuvo un problema?
6. ¿Cómo organiza o consulta usted el historial de un paciente actualmente?
7. ¿Qué tareas relacionadas al seguimiento de pacientes le consumen más tiempo o le resultan más tediosas?
8. ¿Ha tenido alguna vez dificultad para saber si una situación de un paciente ya fue resuelta o sigue pendiente?
9. ¿Qué información suele perderse o ser difícil de rastrear con los métodos que usa actualmente (papel, llamadas, mensajes, etc.)?
10. Si pudiera confiar en una herramienta digital para apoyar su trabajo, ¿qué le generaría confianza para empezar a usarla?
11. ¿Qué le gustaría poder hacer con un solo vistazo al iniciar su jornada, en relación a sus pacientes?
12. ¿Qué tipo de aviso o alerta le resultaría útil recibir, y qué información debería incluir para que usted actúe rápido?
13. Si tuviera que dejar una nota o reporte sobre una situación atendida, ¿cómo le gustaría hacerlo y qué tan simple debería ser ese proceso?

Segmento 2: Familiares y Adultos mayores

1. ¿Cómo se mantiene informado actualmente sobre el estado de salud o bienestar de su familiar adulto mayor cuando no está con él/ella?
2. ¿Qué dificultades enfrenta para estar pendiente de su familiar mientras cumple con su trabajo u otras responsabilidades?
3. ¿Cómo se entera normalmente si algo anormal le ocurrió a su familiar?
4. ¿Qué tan rápido logra enterarse de una situación que requiere su atención, con los medios que usa hoy?
5. Cuando recibe una mala noticia o alerta sobre su familiar, ¿qué es lo primero que necesita saber?
6. ¿Cómo se comunica actualmente con el médico o personal de salud que atiende a su familiar?
7. ¿Qué tareas relacionadas al cuidado de su familiar le consumen más tiempo o le generan más estrés?
8. ¿Ha tenido dificultad para saber si una situación con su familiar ya fue atendida o sigue pendiente?
9. ¿Qué información sobre la salud de su familiar le gustaría tener más a la mano y hoy no la tiene?
10. Si pudiera confiar en una herramienta digital para apoyar el cuidado de su familiar, ¿qué le generaría confianza para empezar a usarla?
11. ¿Qué le gustaría poder ver con un solo vistazo sobre el estado de su familiar al revisar su celular?
12. ¿Qué tipo de aviso o alerta le resultaría útil recibir, y qué información debería incluir?
13. Si tuviera que confirmar que ya atendió una situación de su familiar, ¿cómo le gustaría hacerlo y qué tan simple debería ser?

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento Objetivo: Clínicas y hospitales



Entrevista 1

Nombres y apellidos: Dafne Cabrera Sanchez

Edad: 23 años

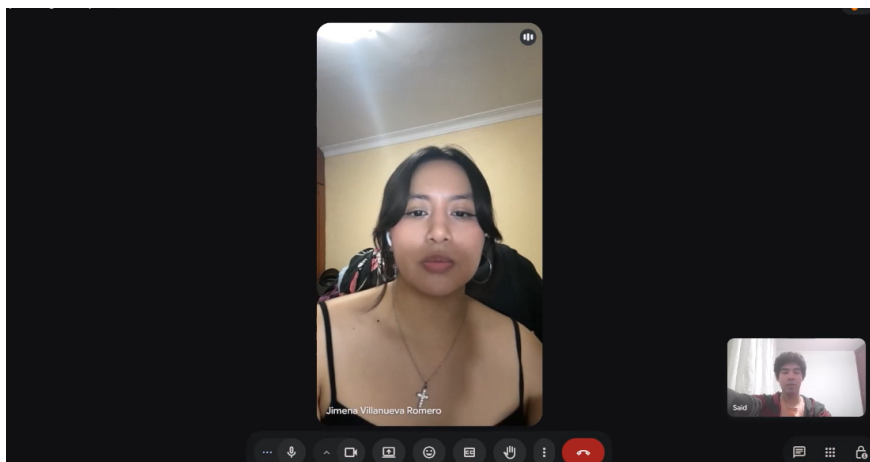
Distrito: San Miguel

Inicio: 00:00

Duración: 4:07

URL: [Ver entrevista 1](#)

Resumen: Dafne Cabrera Sánchez, de 23 años, se desempeña como cuidadora y asistente de salud, donde fue contratada para brindar atención y seguimiento continuo a sus pacientes. Actualmente utiliza notas rápidas, carpetas físicas y llamadas telefónicas para organizar información, comunicarse con la familia y llevar el control de los casos, incluyendo observaciones verbales y pendientes. La supervisión del estado del paciente se realiza mediante llamadas esporádicas o revisiones presenciales cada cierto tiempo, lo que impide contar con información en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva, especialmente cuando ocurren imprevistos entre consultas, obligándola a depender de que alguien la llame para enterarse tarde de las incidencias. Esta situación ha ocasionado episodios de falta de coordinación, duplicidad en las llamadas de atención y pérdida de información importante, además de dificultar la toma de decisiones al no tener los datos centralizados. Para revisar historiales o antecedentes, realiza una búsqueda manual en papeles, aunque reconoce que el proceso podría ser mucho más eficiente. Dafne considera que una solución que permita visualizar de inmediato las alertas urgentes, centralizar el historial y enviar notificaciones automáticas le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la plataforma sea rápida, segura y transparente sobre quién accede a los datos.



Entrevista 2

Nombres y apellidos: Jimena Villanueva Romero

Edad: 22 años

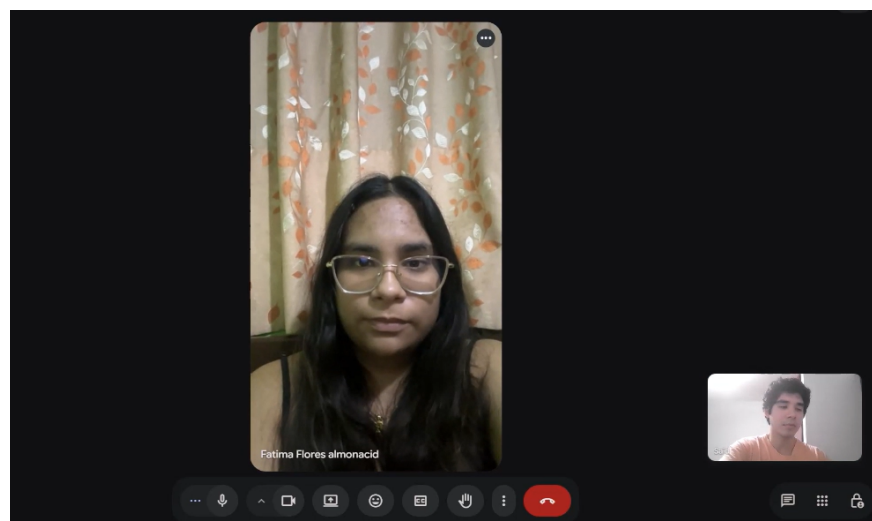
Distrito: Jesus Maria

Inicio: 00:00

Duracion: 5:03

URL: [Ver entrevista 2](#)

Resumen: Jimena Villanueva Romero, de 22 años, se desempeña como médica tratante en un centro de salud, donde fue contratada para brindar atención médica y control de evolución a sus pacientes. Actualmente utiliza el sistema de la institución y papeles dispersos para organizar información, comunicarse con los casos y llevar el registro de sus atenciones. La supervisión del estado de salud de los pacientes se realiza únicamente cuando acuden a consulta presencial, lo que impide contar con seguimiento remoto o información en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva, especialmente fuera de las citas, cuando suelen presentarse complicaciones, obligándola a enterarse tarde de las incidencias en la siguiente cita o ante una emergencia grave. Esta situación ha ocasionado episodios de falta de seguimiento en casos leves y pérdida de control sobre el estado actual de los pacientes, además de dificultar la toma de decisiones al no tener una forma ágil de estar pendiente de todos. Para revisar antecedentes, realiza una búsqueda manual en distintos sistemas o papeles, aunque reconoce que el proceso es tedioso y poco eficiente. Jimena considera que una solución que permita visualizar visualmente la urgencia de los casos pendientes con un solo clic le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la herramienta sea simple y rápida dada su alta carga laboral.



Entrevista 3

Nombres y apellidos: Fatima Flores Almonacid

Edad: 21 años

Distrito: Surco

Inicio: 00:00

Duracion: 3:55

URL: [Ver entrevista 3](#)

Resumen: Fátima Almonacid, de 21 años, se desempeña como cuidadora y asistente de salud, donde fue contratada para brindar acompañamiento y atención continua a sus pacientes. Actualmente utiliza un cuaderno, notas en el celular y mensajes de WhatsApp para organizar información, comunicarse con

la familia y llevar el control informal de los casos. La supervisión del estado de los pacientes se realiza únicamente cuando la familia le escribe o llama, lo que impide contar con información constante, ordenada o en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva y dependiente de canales informales, donde a veces se entera de inmediato y otras horas después. Esta situación ha ocasionado episodios de pérdida del hilo en algunos casos y olvido de detalles importantes conversados informalmente, además de dificultar la toma de decisiones al no tener un historial ordenado. Para revisar antecedentes o reconstruir información tras cambiar de dispositivo, realiza una búsqueda manual en sus notas dispersas, reconociendo que el proceso es vulnerable y poco eficiente. Fátima considera que una solución que permita ver un resumen diario de casos activos, recibir alertas claras con el motivo y registrar acciones mínimas de forma rápida le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la plataforma sea clara sobre la privacidad y el manejo seguro de la información.

Segmento Objetivo: Familiares y Adultos Mayores



Entrevista 4

Nombres y apellidos: Samir Choquehuanca Miranda

Edad: 22 años

Distrito: Lince

Inicio: 00:00

Duración: 5:08

URL: [Ver entrevista 4](#)

Resumen: Samir Choquehuanca Miranda, de 22 años, se desempeña como familiar cuidador y soporte principal, donde asumió la responsabilidad de velar por el bienestar y la seguridad de su madre. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y la coordinación informal con sus hermanos para organizar la atención, comunicarse con la familia y llevar el control diario de su cuidado, incluyendo recordatorios de medicamentos y avisos de vecinos. La supervisión del estado de su madre se realiza mediante llamadas esporádicas dos o tres veces al día, lo que impide contar con información constante o en tiempo real mientras él se encuentra ocupado en su trabajo. Esto genera una gestión reactiva y generadora de culpa, enterándose muchas veces a través de terceros o de su propia madre cuando ya pasó el problema. Esta situación ha ocasionado episodios de duplicidad en las llamadas, incertidumbre sobre quién ya la contactó y dificultades para actuar rápido ante imprevistos, además de la fatiga que implica coordinar todo manualmente. Para conocer su estado, depende de la comunicación directa o de reportes tardíos, reconociendo que el proceso es agotador y poco eficiente. Samir considera que una solución que permita ver de inmediato si todo está en orden, recibir alertas claras sobre su condición y registrar la atención con un solo botón le ayudaría a ahorrar tiempo y reducir la preocupación, priorizando que la plataforma garantice la privacidad y protección de los datos de su madre.



Entrevista 5

Nombres y apellidos: Walter Junior Navarro

Edad: 25 años

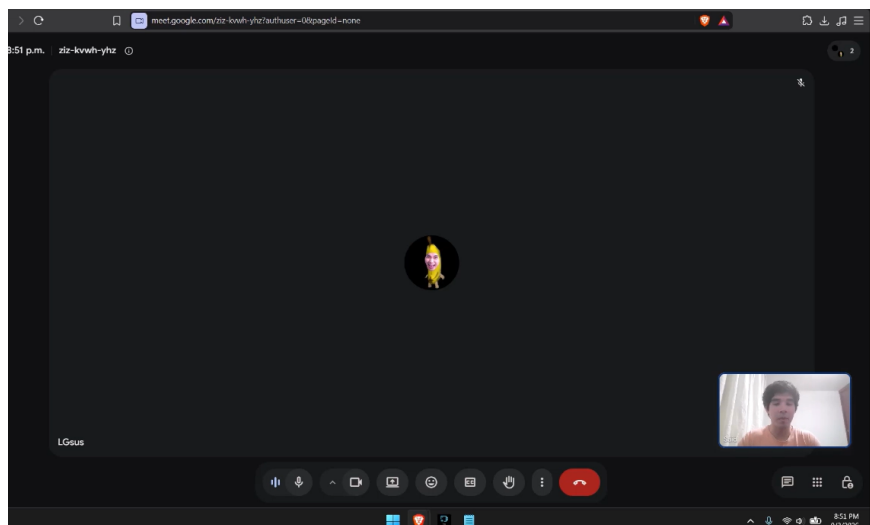
Distrito: Barranco

Inicio: 00:00

Duración: 4:11

URL: [Ver entrevista 5](#)

Resumen: Walter Navarro, de 25 años, se desempeña como familiar cuidador a distancia, donde asumió la responsabilidad de velar por el bienestar y la seguridad de su ser querido desde otra ciudad. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y la coordinación informal con vecinos para organizar el apoyo, enterarse de su estado y llevar un control improvisado de la situación. La supervisión del bienestar de su familiar se realiza de forma indirecta, lo que le impide contar con información en tiempo real debido a la distancia física. Esto genera una gestión reactiva y de constante preocupación, enterándose muchas veces al día siguiente o a través de terceros cuando ya pasó la emergencia. Esta situación ha ocasionado episodios de incertidumbre sobre si alguien ya fue a verla y dificultades para coordinar la ayuda oportuna, además del estrés que implica no tener comunicación con su entorno médico. Para conocer su estado, depende totalmente de que alguien le avise, reconociendo que este proceso es desgastante y poco confiable. Walter considera que una solución que permita ver un estado simple al abrir la app, recibir alertas claras sobre quién ya la atendió y confirmar acciones con un solo botón le ayudaría a reducir la ansiedad y mejorar la gestión, priorizando que la herramienta sea confiable y muy sencilla de usar.



Entrevista 6

Nombres y apellidos: Jesus Arrollo

Edad: 26 años

Distrito: Surco

Inicio: 00:00

Duracion: 4:31

URL: [Ver entrevista 6](#)

Resumen: Jesús Arroyo, de 26 años, se desempeña como usuario y paciente que busca gestionar su propio bienestar, donde asumió la responsabilidad de cumplir con su tratamiento y cuidado personal. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y recordatorios mentales para organizar su rutina, comunicarse con su familia y llevar el control independiente de sus medicamentos. La supervisión de su estado de salud se realiza mediante su propia iniciativa, lo que impide contar con un registro constante debido a olvidos frecuentes cuando cambia de rutina o se distrae. Esto genera una gestión reactiva y basada en la duda, prefiriendo no molestar a los demás con cosas menores, como le ocurrió cuando se sintió mareado y no avisó a nadie. Esta situación ha ocasionado episodios de descuido en la toma de pastillas y falta de reportes a tiempo ante molestias físicas, además de la incomodidad de sentirse vigilado a pesar de entender que es por su bien. Para recordar sus horarios o pedir ayuda, depende de su memoria o de su celular para llamadas, reconociendo que le cuesta usar aplicaciones complejas. Jesús considera que una solución que permita avisar rápido si necesita ayuda, contar con recordatorios claros y utilizar botones grandes sin configuraciones complicadas le ayudaría a sentirse más seguro y organizado, priorizando que la plataforma sea muy sencilla, con letras grandes y que proteja estrictamente la privacidad de sus datos frente a terceros.

2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento Objetivo: Clínicas y hospitales

1. Rol Principal

- **100% da seguimiento y atención a pacientes adultos mayores**, ya sea en clínica, centro de salud comunitario o consulta independiente.

2. Contexto

- **Entornos de atención:** Médicos con distintos entornos (clínica privada, centro de salud público, atención a domicilio), todos **sin sistema digital de seguimiento remoto**.
- **Herramientas actuales:**

- **100%** usa métodos manuales o informales (papel, cuaderno, memoria, WhatsApp/llamadas).
- **33%** usa un sistema institucional, pero lo considera lento e insuficiente para seguimiento continuo.
- **100%** depende de comunicación informal por WhatsApp o llamada telefónica con la familia del paciente para enterarse de novedades.

3. Problemas Comunes

- **100%:** No se entera a tiempo de situaciones que requieren atención; depende de que un tercero le avise.
- **100%:** Dificultad para acceder al historial del paciente de forma centralizada y ordenada.
- **100%:** No sabe con certeza si una situación ya fue atendida o sigue pendiente.
- **100%:** Se pierde información relevante (observaciones verbales, notas informales) que nunca queda registrada formalmente.
- **33%:** Alta carga de pacientes le impide dar seguimiento incluso a casos leves.

4. Frecuencia de Seguimiento

- **33%** depende de llamadas periódicas sin constancia fija.
- **33%** solo reactivo (ante emergencia).
- **33%** depende completamente de terceros informales, sin ningún orden.

5. Datos Deseados Automáticamente

- **100%** quiere ver: qué ocurrió, cuándo, y nivel de urgencia, de forma inmediata y sin tener que buscar en otro lado.
- **100%** quiere una vista resumen que priorice los casos más urgentes antes de entrar al detalle.

6. Transparencia y Confianza

- **100%** requiere que quede claro quién accede a la información del paciente.
- **66%** señala explícitamente la necesidad de que la fuente de datos sea confiable y no dependa de terceros no autorizados.

7. Registro de Acciones

- **100%** quiere confirmar la atención de un caso de forma mínima (campo corto / un clic), sin formularios largos.

8. Adopción de la Aplicación

- **100%** dispuesto a adoptarla si es simple y no representa una curva de aprendizaje alta, dada su carga de trabajo actual.

Segmento Objetivo: Familiares y Adultos mayores

1. Rol Principal

- **100%** forma parte del entorno de cuidado directo del adulto mayor — ya sea como quien necesita estar informado (familiar) o como quien genera la información de salud (adulto mayor).

2. Contexto

- **Perfiles con distintos grados de cercanía física:** Mismo distrito, otra ciudad, y el propio adulto mayor que vive solo, todos **sin ningún sistema digital de monitoreo o registro**.
- **Herramientas actuales:**
 - **100%** depende de comunicación informal (llamadas telefónicas) como método principal.
 - **66%** depende de terceros no autorizados formalmente (vecinos) para enterarse de una situación.
 - **100%** no tiene comunicación directa ni sistema con el médico tratante.
 - **33%** (adulto mayor) no usa ningún dispositivo, solo celular para llamar.

3. Problemas Comunes

- **100%:** Se entera tarde de una situación de salud, horas o hasta un día después.
- **66%:** No sabe si otro familiar ya atendió la situación, generando incertidumbre y posible duplicidad de esfuerzos.
- **66%:** La coordinación entre familiares o terceros para dar seguimiento es agotadora o poco confiable.
- **33%:** El propio adulto mayor evita avisar cuando cree que el problema es “menor”, ocultando síntomas.
- **33%:** Episodios de riesgo (mareo) sin que se buscara ayuda a tiempo.

4. Frecuencia de Contacto / Autocontrol

- **100%** sin frecuencia fija — reactivo ante llamadas o episodios, sin revisión programada ni recordatorios.

5. Datos Deseados Automáticamente

- **100%** quiere un estado general inmediato tipo “todo bien / necesita atención” al abrir la app.
- **100%** (familiares) quiere saber qué pasó, qué tan grave es y si alguien ya está atendiendo, sin tener que llamar para confirmar.
- **100%** (adulto mayor) quiere poder avisar rápido que necesita ayuda sin explicar mucho.

6. Transparencia y Privacidad

- **100%** requiere que la información esté protegida y solo accesible por quienes están autorizados.
- **33%:** Preocupación explícita de que personas ajenas a la familia (no solo desconocidos, sino terceros no autorizados) puedan ver los datos.
- **33%:** Cierta incomodidad inicial con sentirse “vigilado”, aunque lo acepta como beneficio.

7. Registro de Acciones

- **100%** quiere confirmar una acción (contacto/atención) con el mínimo esfuerzo posible — un botón, sin formularios ni trámites largos.

8. Facilidad de Uso

- **33%** (adulto mayor) requiere específicamente botones grandes, pocos pasos y cero configuración recurrente, por baja familiaridad con tecnología.
- **100%** en general prioriza simplicidad sobre funcionalidad avanzada.

9. Adopción de la Aplicación

- **100%** dispuesto a adoptarla si reduce la incertidumbre actual y no representa un proceso complicado; para el adulto mayor la adopción depende casi exclusivamente de la simplicidad extrema del diseño.

2.3. Needfinding

El proceso de Needfinding permitió identificar las principales necesidades, dificultades y expectativas de los usuarios que participan en el cuidado y seguimiento de adultos mayores. Para ello, se analizaron las entrevistas realizadas a representantes de los segmentos objetivo de VitaLink: Clínicas y hospitales y Familiares y adultos mayores. Los hallazgos evidencian que actualmente el seguimiento de los adultos mayores depende principalmente de llamadas telefónicas, WhatsApp, notas físicas y otros medios informales. Esta situación genera información dispersa, comunicación tardía, dificultad para conocer el estado actual del adulto mayor y problemas para coordinar quién se encuentra atendiendo una situación determinada. A partir de estos resultados se desarrollaron los siguientes artefactos de Needfinding: User Personas, User Task Matrix, User Journey Mapping y Empathy Mapping. Estos permiten representar las características de los usuarios, sus tareas actuales, la experiencia que atraviesan y los principales puntos de dolor y oportunidades identificados durante las entrevistas.

2.3.1. User Personas

A partir de las entrevistas realizadas se construyeron los User Personas correspondientes a los segmentos objetivo de VitaLink. Cada persona representa las características, necesidades, comportamientos, motivaciones y dificultades identificadas en los usuarios entrevistados. Para la elaboración de estos perfiles se utilizó UXPressia, siguiendo las indicaciones establecidas para el desarrollo de los artefactos de Needfinding. Se desarrollaron dos User Personas principales: Dafne Cabrera Sánchez, como representante del segmento de clínicas y hospitales, y Samir Choquehuanca Miranda, como representante del segmento de familiares y adultos mayores.

2.3.1.1 User Persona – Clínicas y hospitales

2.3.1.2 User Persona – Familiares y adultos mayores

2.3.2. User Task Matrix

La User Task Matrix permite identificar las principales tareas que los usuarios realizan actualmente dentro del proceso de cuidado y seguimiento de adultos mayores, independientemente de la existencia de VitaLink. Las tareas fueron identificadas a partir de las entrevistas realizadas y se clasificaron según los usuarios involucrados, su frecuencia y su nivel de importancia.

User Task Matrix					
N.º	Tarea actual	Dafne	Samir	Frecuencia	Importancia
1	Supervisar el estado del adulto mayor	✓	✓	Alta	Alta
2	Comunicarse con el adulto mayor	✓	✓	Alta	Alta
3	Comunicarse con familiares o responsables	✓	✓	Alta	Alta
4	Identificar situaciones que requieren atención	✓	✓	Media	Alta
5	Informar sobre un incidente o cambio de estado	✓	✓	Media	Alta
6	Confirmar que una situación fue atendida	✓	✓	Media	Alta
7	Consultar información previa del adulto mayor	✓	—	Media	Alta
8	Registrar observaciones sobre el estado del adulto mayor	✓	—	Alta	Alta
9	Coordinar la atención con otras personas responsables	✓	✓	Alta	Alta
10	Realizar llamadas de seguimiento	✓	✓	Alta	Media
11	Verificar información proporcionada por terceros	✓	✓	Media	Alta
12	Mantener informados a otros responsables	✓	✓	Media	Alta

Análisis de la User Task Matrix La matriz evidencia que las tareas más críticas para ambos perfiles son la **supervisión del adulto mayor**, la **comunicación**, la **identificación de situaciones que requieren atención**, la **coordinación** y la **confirmación de que una situación fue atendida**.



Figure 1: User Persona – Clínicas y hospitales

PERSONA: Samir Choquehuanca

Descripción de la persona

DESCRIPCIÓN

Es el principal responsable del bienestar y seguridad de su madre. Debido a sus actividades laborales, no puede permanecer constantemente con ella y actualmente utiliza llamadas telefónicas y coordinación informal con sus hermanos y vecinos para conocer su estado.

NAME

Samir Choquehuanca

TYPE

Rational



Objetivos

- Saber oportunamente si su familiar se encuentra bien.
- Detectar situaciones que requieren atención.
- Coordinar el cuidado con otros familiares.
- Saber quién está atendiendo una situación.
- Reducir la incertidumbre durante el tiempo en que se encuentra lejos.

Necesidades

- Conocer rápidamente el estado general del adulto mayor.
- Recibir información sobre situaciones relevantes.
- Saber qué ocurrió y qué nivel de atención requiere.
- Conocer si otra persona ya se hizo cargo.
- Contar con una forma sencilla de solicitar ayuda.
- Mantener protegida la información familiar.

Demographic

♂ Male 22 years

📍 Lima

Frase representativa

“Quiero saber rápidamente si está bien y, si ocurre algo, saber quién se está encargando.”

Habilidades

Organización



Paciencia



Solución de problemas



Frustraciones

- Enterarse tarde de problemas de salud.
- Tener que realizar varias llamadas para obtener información.
- No saber si otro familiar ya se comunicó.
- Coordinar constantemente de manera manual.
- Depender de vecinos o terceros.
- Sentir incertidumbre cuando no puede estar presente.

Motivaciones

- Proteger a su familiar.
- Tener mayor tranquilidad mientras trabaja.
- Reducir llamadas innecesarias.
- Mejorar la coordinación familiar.
- Poder reaccionar rápidamente ante una situación.

Preocupaciones

- Privacidad de la información.
- Acceso de personas no autorizadas.
- No enterarse oportunamente de una emergencia.
- Falta de claridad sobre quién está atendiendo al adulto mayor.

Expectativas

- Información sencilla y rápida.
- Estado general fácilmente comprensible.
- Pocas acciones para registrar una atención.
- Comunicación clara.
- Uso sencillo para el adulto mayor.

Canales



WhatsApp



Celular



Llamadas

Navegadores



Chrome

Tecnología



UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Figure 2: User Persona – Familiares y adultos mayores
32

En el caso de **Dafne**, también adquieren especial importancia la **consulta de información previa** y el **registro de observaciones**, debido a su responsabilidad directa sobre el seguimiento de pacientes.

En el caso de **Samir**, destacan las tareas relacionadas con la **comunicación y coordinación familiar**, debido a que actualmente depende de llamadas y de terceros para conocer el estado de su familiar.

Estas tareas representan actividades que los usuarios ya realizan en su contexto actual y permiten identificar oportunidades para **reducir esfuerzos, tiempos de coordinación e incertidumbre**.

2.3.3. User Journey Mapping

Se elaboraron los User Journey Maps para representar la experiencia actual (As-Is) de los usuarios durante el seguimiento y cuidado de adultos mayores. Los mapas permiten identificar las principales etapas del proceso, las acciones realizadas, los pensamientos y emociones de los usuarios, los puntos de dolor y las oportunidades de mejora. Para su elaboración se utilizó **UXPressia**.

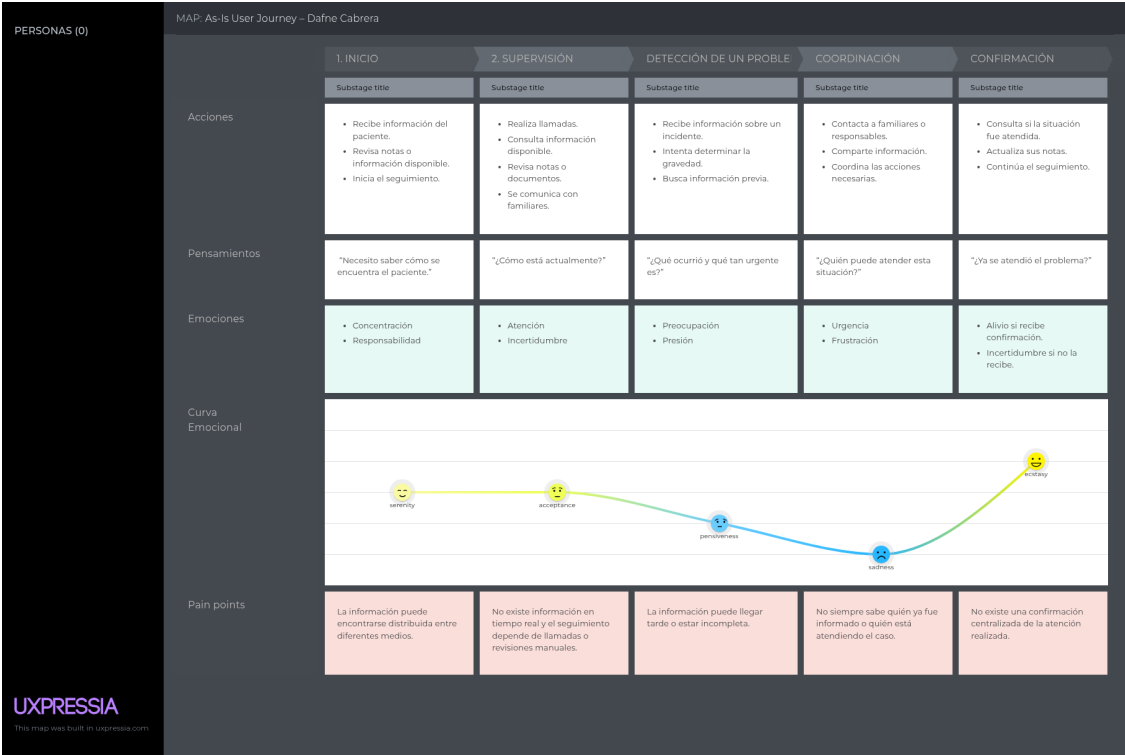


Figura 3: User Journey Map - Clínicas y hospitales

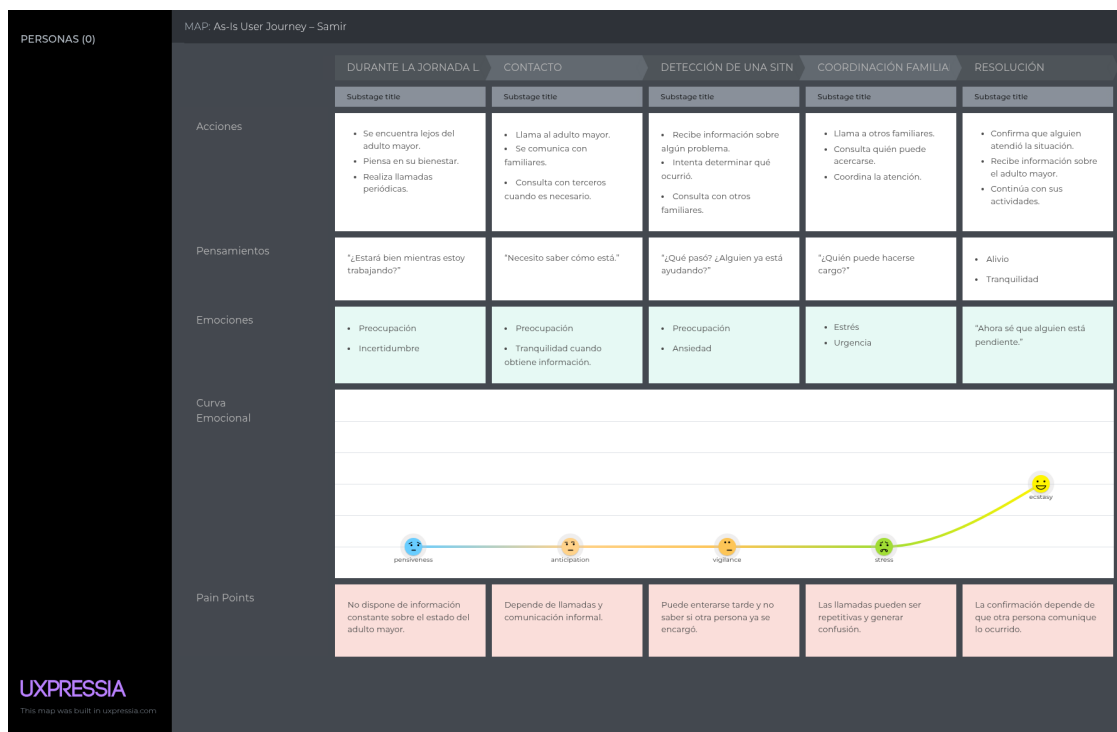


Figura 4: User Journey Map - Familias y Adulto Mayor

2.3.4. Empathy Mapping

Se elaboraron los Empathy Maps de los User Personas con el propósito de comprender con mayor profundidad lo que los usuarios expresan, observan, realizan, escuchan, piensan y sienten durante el proceso actual de cuidado y seguimiento del adulto mayor. Los mapas también permiten identificar los principales Pains y Gains de cada perfil. Para su elaboración se utilizó UXPressia. La Figura 5 presenta el Empathy Map de Dafne, elaborado a partir de sus respuestas y experiencias durante el proceso actual de seguimiento de pacientes.

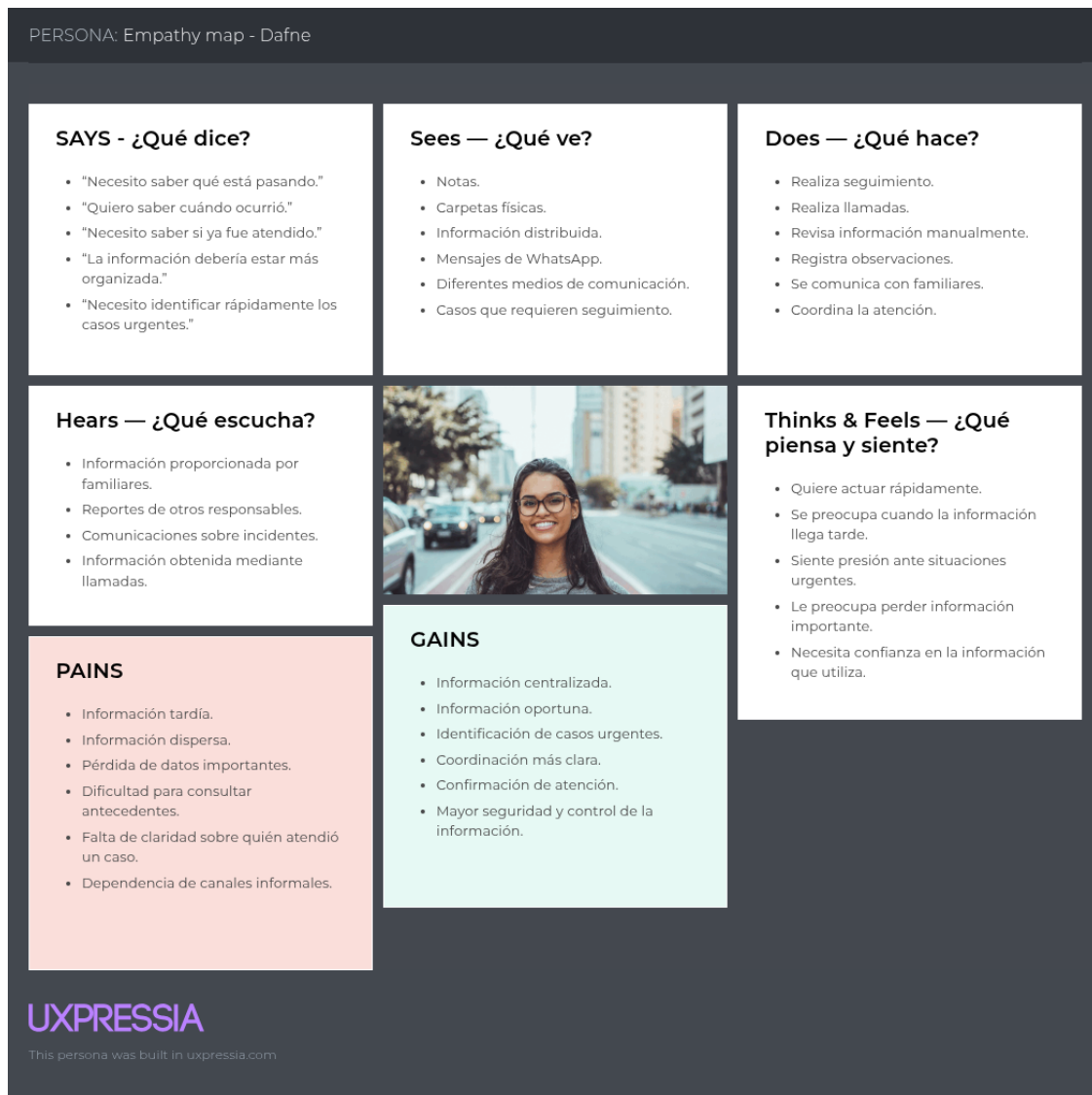


Figura 5: Empathy Map - Clínicas y hospitales



Figura 6: Empathy Map - Familiares y Adulto Mayor

Síntesis del Needfinding

El análisis conjunto de los **User Personas**, **User Task Matrix**, **User Journey Maps** y **Empathy Maps** permite identificar cinco necesidades transversales en los usuarios entrevistados:

1. **Información oportuna:** los usuarios necesitan conocer el estado del adulto mayor sin depender exclusivamente de llamadas o comunicaciones tardías.
2. **Información centralizada:** tanto el personal de salud como los familiares enfrentan dificultades debido a la dispersión de información en notas, documentos, llamadas y mensajes.
3. **Priorización de situaciones:** los usuarios necesitan distinguir rápidamente aquellas situaciones que requieren atención inmediata.
4. **Coordinación entre responsables:** existe incertidumbre respecto a quién recibió la información, quién está atendiendo un caso y si la situación ya fue resuelta.

5. **Privacidad y seguridad:** los usuarios consideran importante conocer quién puede acceder a la información del adulto mayor y que los datos permanezcan protegidos.

En consecuencia, la principal necesidad identificada es **reducir la incertidumbre** asociada al estado y cuidado del adulto mayor, facilitando el acceso oportuno a información relevante y la coordinación entre las personas responsables.

Para el **personal de salud**, esto implica contar con mayor claridad sobre los casos que requieren seguimiento y sobre las acciones realizadas. Para los **familiares**, implica conocer de manera sencilla si el adulto mayor se encuentra bien, si requiere atención y si alguna persona ya está encargándose de la situación.

Estos hallazgos constituyen la base para definir posteriormente las necesidades funcionales y las oportunidades de diseño de **VitaLink**.

2.4. Big Picture Event Storming

2.5. Ubiquitous Language

El Ubiquitous Language de SeniorCare establece los principales términos utilizados dentro del dominio de la solución. Su propósito es mantener un lenguaje común entre los integrantes del equipo y evitar diferentes interpretaciones sobre los conceptos relacionados con el seguimiento y cuidado del adulto mayor.

Term	Definición
Older Adult	Persona adulta mayor cuyo estado y seguimiento son gestionados mediante SeniorCare.
Family Caregiver	Familiar o cuidador responsable de acompañar y realizar el seguimiento del adulto mayor.
Care Provider	Profesional u organización de atención que puede ser contactado para coordinar la atención del adulto mayor.
Preventive Monitoring	Proceso continuo de seguimiento de la información relacionada con el estado del adulto mayor.
Health Information	Información registrada sobre el estado de salud del adulto mayor y utilizada durante su seguimiento.
Health Status	Estado actual del adulto mayor obtenido a partir de la información registrada durante su monitoreo.
Risk Situation	Situación identificada durante el monitoreo que puede representar un riesgo para el adulto mayor.
Alert	Aviso generado cuando se detecta una situación de riesgo que requiere informar al familiar o cuidador.
Notification	Comunicación enviada al familiar o cuidador para informarle sobre una alerta generada.
Care Coordination	Proceso mediante el cual se organiza la atención del adulto mayor con un proveedor de atención.
Care Record	Registro de la atención realizada al adulto mayor como parte de su seguimiento.
Follow-up	Actualización y consulta continua de la información relacionada con el estado y atención del adulto mayor.

3. Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP-01	Landing Page	Sitio web estático con vistas segmentadas para captar pacientes/familiares y profesionales de salud.	-	-
US-01	Propuesta de valor segmentada en Landing Page	Como visitante, quiero entender en segundos qué problema resuelve VitaLink, para decidir si me interesa conocer más.	Dado que el visitante ingresa a la Landing Page, Cuando la página carga, Entonces el médico debe visualizar el titular “Optimice el seguimiento preventivo”, y el familiar el titular “La tranquilidad de saber que tus padres están bien”.	EP-01
US-02	Explicación del funcionamiento del sistema	Como visitante, quiero entender cómo funciona la plataforma paso a paso, para evaluar su utilidad.	Dado que el usuario explora la página, Cuando llega a la sección de funcionamiento, Entonces el médico debe ver el “Flujo clínico integrado”, y el familiar los “Cuatro pilares fundamentales” del servicio.	EP-01
US-03	Visualización de Planes y Suscripciones	Como visitante, quiero conocer las opciones de planes y sus costos, para elegir el que mejor se adapte a mi necesidad.	Dado que el visitante navega a la sección de tarifas, Cuando revisa los planes, Entonces el sistema debe mostrar 3 opciones de suscripción específicas para su perfil (Básica/Pro/Institucional o Básico/Familiar/Plus) con sus respectivos precios.	EP-01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-04	Sección de privacidad y seguridad de datos	Como profesional de salud, quiero ver una sección de seguridad de datos, para confiar en registrar información clínica.	Dado que un profesional de salud explora la landing page, Cuando navega hacia la sección respectiva, Entonces debe visualizar los protocolos de "Seguridad de grado médico", incluyendo cifrado E2E, HIPAA & GDPR y control de acceso.	EP-01
US-05	Respaldo mediante Testimonios	Como familiar, quiero leer historias de otras familias y médicos, para confiar en la efectividad del sistema.	Dado que un familiar evalúa la confiabilidad del servicio, Cuando visualiza la landing page, Entonces debe encontrar una sección con al menos tres testimonios reales de usuarios que respaldan la aplicación.	EP-01
US-06	Interfaz de captura de leads (Botones de acción)	Como visitante, quiero botones claros para iniciar mi registro o pedir información, para comenzar a usar la plataforma.	Dado que el visitante decide adoptar la plataforma, Cuando interactúa con los llamados a la acción, Entonces el familiar debe ser dirigido al registro mediante "Crear cuenta", y el médico al contacto mediante "Unirme como proveedor" o "Solicitar información técnica".	EP-01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-07	Mockups visuales del producto	Como visitante, quiero ver ejemplos de la interfaz real, para entender rápidamente cómo se recibe la información.	Dado que un visitante revisa las funcionalidades, Cuando observa las imágenes ilustrativas, Entonces el médico debe ver un dashboard clínico en monitor, y el familiar una notificación de alerta en su smartphone.	EP-01
EP-02	Frontend (Vista Médico)	Interfaz de usuario para que los profesionales de salud gestionen pacientes y alertas.	-	-
US-08	Resumen inicial de alertas pendientes	Como médico, quiero ver un resumen inicial con pacientes pendientes, para priorizar mi atención al iniciar el día.	Dado que el médico inicia su jornada en la aplicación, Cuando accede a la pantalla principal, Entonces el sistema debe mostrar el número total de alertas pendientes y permitir la navegación hacia la lista completa.	EP-02
US-09	Nivel de urgencia visual en cada alerta	Como médico, quiero ver el nivel de urgencia visual, para decidir rápido qué revisar primero.	Dado que el médico revisa la lista de alertas, Cuando el sistema carga los datos, Entonces cada alerta debe mostrar una etiqueta que clasifique visualmente su urgencia (alto, medio o bajo) permitiendo ordenarlas.	EP-02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-10	Acceso al detalle de paciente desde el resumen	Como médico, quiero acceder al detalle de un paciente desde el resumen, para revisar contexto sin buscar en varias pantallas.	Dado que el médico necesita más información de un caso, Cuando selecciona una alerta específica, Entonces el sistema debe navegar al expediente detallado del paciente manteniendo una opción de regreso al resumen.	EP-02
US-11	Historial de registros del paciente ordenado	Como médico, quiero ver el historial ordenado por fecha, para entender la evolución sin papeles dispersos.	Dado que el médico visualiza el detalle de un paciente, Cuando accede a la sección de historial, Entonces debe visualizar los eventos organizados cronológicamente, o un mensaje informativo si no existen registros previos.	EP-02
US-12	Marcar alerta como en revisión o atendida	Como médico, quiero marcar una alerta como “en revisión” o “atendida”, para que otros sepan el estado del caso.	Dado que el médico gestiona una situación de riesgo, Cuando ejecuta la acción de cambiar el estado de la alerta, Entonces el sistema debe reflejar la actualización inmediatamente en el listado general de alertas.	EP-02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-13	Observación breve al atender una alerta	Como médico, quiero agregar una observación breve al atender una alerta, para dejar registro rápido de lo ocurrido.	Dado que el médico actualiza el estado de un incidente, Cuando finaliza la acción, Entonces el sistema debe habilitar un campo opcional para registrar observaciones asociadas a la fecha y nombre del médico.	EP-02
US-14	Visibilidad de revisión previa por otro profesional	Como médico, quiero ver si un caso ya fue revisado, para evitar duplicar esfuerzos.	Dado que el médico analiza la lista de pendientes, Cuando visualiza las alertas, Entonces el sistema debe distinguir claramente aquellas que ya poseen revisión previa e indicar qué profesional interactuó con ellas.	EP-02
EP-03	Backend (API RESTful)	Lógica de servidor, base de datos y procesamiento de reglas de negocio.	-	-
US-15	Generación automática de alerta desde un evento	Como Developer, quiero registrar un evento y generar una alerta asociada mediante API, para iniciar el flujo de atención.	Dado que el servidor recibe una solicitud de registro de evento, Cuando los datos cumplen los parámetros de riesgo configurados, Entonces la API debe generar una alerta asociada, o retornar un error si los datos son inválidos.	EP-03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-16	Asignación de nivel de prioridad a alertas	Como Developer, quiero asignar un nivel de prioridad a cada alerta, para permitir su ordenamiento en el frontend.	Dado que el sistema procesa la creación de una nueva alerta, Cuando evalúa el payload de entrada, Entonces debe asignar y almacenar un nivel de prioridad que quedará expuesto a través del endpoint correspondiente.	EP-03
US-17	Almacenamiento del historial del paciente	Como Developer, quiero almacenar el historial de un paciente, para permitir consultas posteriores.	Dado que el backend recibe acciones o alertas de un paciente, Cuando procesa la solicitud, Entonces debe persistir la información en la base de datos permitiendo futuras consultas filtradas por rango de fechas.	EP-03
US-18	Trazabilidad de atención de alertas	Como Developer, quiero registrar quién atendió una alerta y cuándo, para mantener trazabilidad.	Dado que se ejecuta un endpoint de cambio de estado de alerta, Cuando la transacción es exitosa, Entonces la base de datos debe registrar el timestamp exacto y el identificador del profesional responsable.	EP-03
US-19	Cambio de estado de alerta sin eliminar	Como Developer, quiero cambiar el estado de una alerta sin eliminarla, para conservar el historial completo.	Dado que el sistema recibe una solicitud para dar por cerrada una alerta, Cuando actualiza el registro, Entonces debe aplicar un soft-delete o actualizar su estado lógico, manteniendo la persistencia física de los datos.	EP-03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-20	Asociación de paciente con proveedor de salud	Como Developer, quiero asociar a cada paciente un proveedor de salud, para vincular la información clínica.	Dado que se envía la configuración de un paciente a la API, Cuando incluye un identificador de proveedor, Entonces el sistema debe validar y registrar la vinculación única, o marcarlo como "sin vincular" si es omitido.	EP-03
US-21	Validación de datos básicos del paciente	Como Developer, quiero validar que los datos básicos estén completos, para asegurar información mínima confiable.	Dado que se solicita la activación del seguimiento clínico, Cuando el payload carece de campos obligatorios, Entonces la API debe retornar un código de error detallando específicamente qué atributos faltan.	EP-03
EP-04	Frontend (Vista Familiar / Cuidador)	Interfaz para que la red de apoyo supervise el estado del adulto mayor.	-	-
US-22	Panel visual del estado general	Como familiar cuidador, quiero ver un estado general y simple al abrir la app, para reducir mi ansiedad cuando estoy lejos.	Dado que el familiar inicia sesión en la aplicación móvil, Cuando carga la pantalla de inicio, Entonces debe visualizar un indicador claro en tiempo real sobre el bienestar del adulto mayor sin necesidad de navegar más profundo.	EP-04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-23	Confirmación rápida de atención de alertas	Como familiar cuidador, quiero confirmar con un solo botón que estoy atendiendo una alerta, para avisar a mi familia rápidamente.	Dado que el sistema reporta una situación irregular, Cuando el familiar interactúa con la notificación, Entonces debe disponer de un botón visible que marque la alerta como “atendida por familiar” informando a la red de cuidadores.	EP-04
US-24	Visualización de información centralizada	Como familiar, quiero ver si otro familiar ya atendió un caso, para evitar coordinaciones telefónicas duplicadas.	Dado que ocurre un incidente, Cuando el familiar revisa el historial en la aplicación, Entonces el sistema debe indicar si algún miembro de la red de cuidadores o médico ya se hizo cargo de la situación.	EP-04

3.2. Impact Mapping

Table 2: Impact Mapping de Vitalink

Objetivo de Negocio (Why)	Actores (Who)	Impacto (How)	Entregables (What)
Reducir el tiempo de respuesta ante situaciones de riesgo detectadas, sustituyendo la dependencia de la supervisión presencial constante.	Familiares y cuidadores	Obtener información oportuna ante una situación que requiera intervención, mediante notificaciones automáticas.	Sistema de alertas automáticas
Incrementar la adopción de mecanismos de monitoreo preventivo entre familias con adultos mayores durante los primeros meses de operación.	Familiares y cuidadores responsables del adulto mayor	Obtener acceso continuo a información relevante sobre el estado del adulto mayor, incluso sin estar presentes físicamente.	Funcionalidad de monitoreo preventivo de indicadores relevantes

Objetivo de Negocio (Why)	Actores (Who)	Impacto (How)	Entregables (What)
Consolidar alianzas con clínicas, hospitales y profesionales de salud que se integren como proveedores de atención dentro del ecosistema.	Clínicas y hospitales	Recibir alertas y datos relevantes de manera oportuna, facilitando una gestión de atención más ágil y mejor informada.	Canal de comunicación familiar-proveedor
Mejorar el seguimiento del estado del adulto mayor y facilitar la toma de decisiones ante un incidente.	Familiares, cuidadores y proveedores de atención	Obtener acceso organizado a la información del adulto mayor desde un único lugar, actualmente dispersa entre distintos actores.	Centralización de información de salud
Brindar mayor seguridad y acompañamiento al adulto mayor durante sus actividades cotidianas, incluso sin compañía física.	Adultos mayores	Contar con un sistema que identifique de manera temprana posibles situaciones de riesgo.	Monitoreo preventivo y sistema de alertas
Incrementar la frecuencia de uso de la plataforma por parte de familiares y cuidadores.	Familiares y cuidadores	Obtener una visión clara y rápida del estado general del adulto mayor sin necesidad de encontrarse físicamente con él.	Panel de seguimiento remoto

3.3. Product Backlog.

Table 3: Product Backlog de VitaLink

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
1	US-01	Propuesta de valor clara en Landing Page	Como visitante médico, quiero entender en segundos qué problema resuelve VitaLink, para decidir si me interesa conocer más.	2
2	US-02	Sección de privacidad y seguridad de datos	Como profesional de salud, quiero ver una sección de privacidad/seguridad de datos, para confiar en registrar información de mis pacientes.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
3	US-03	Botón para solicitar información	Como profesional de salud, quiero un botón claro para “solicitar información” antes de registrarme, para evaluar la herramienta sin compromiso.	3
4	US-04	Respaldo de clínicas e instituciones	Como profesional de salud, quiero ver quiénes respaldan la plataforma (clínicas/instituciones), para confiar en su legitimidad.	2
5	US-05	Sección de preguntas frecuentes	Como profesional de salud, quiero ver una sección de preguntas frecuentes, para resolver dudas sin tener que contactar a alguien.	3
6	US-06	Botón para unirse como proveedor de salud	Como profesional de salud, quiero un botón específico para “unirme como proveedor de salud”, para iniciar mi registro directamente.	2
7	US-07	Ejemplo visual de una alerta	Como profesional de salud, quiero ver un ejemplo visual simple de cómo se ve una alerta, para entender rápido cómo funciona el seguimiento.	3
8	US-15	Generación automática de alerta desde un evento	Como sistema, quiero registrar un evento y generar automáticamente una alerta asociada, para iniciar el flujo de atención.	8

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
9	US-16	Asignación de nivel de prioridad a alertas	Como sistema, quiero asignar un nivel de prioridad a cada alerta, para permitir su ordenamiento en el frontend.	5
10	US-08	Resumen inicial de alertas pendientes	Como médico, quiero ver un resumen inicial con la cantidad de pacientes con alertas pendientes, para priorizar mi atención al iniciar el día.	5
11	US-09	Nivel de urgencia visual en cada alerta	Como médico, quiero ver el nivel de urgencia de cada alerta de forma visual (color/etiqueta), para decidir rápido qué revisar primero.	3
12	US-10	Acceso al detalle de paciente desde el resumen	Como médico, quiero acceder al detalle de un paciente desde el resumen, para revisar contexto sin buscar en varias pantallas.	3
13	US-19	Cambio de estado de alerta sin eliminar	Como sistema, quiero cambiar el estado de una alerta (pendiente/en revisión/atendida/cerrada) sin eliminarla, para conservar el historial completo.	5
14	US-12	Marcar alerta como en revisión o atendida	Como médico, quiero marcar una alerta como "en revisión" o "atendida", para que otros sepan el estado del caso.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
15	US-18	Trazabilidad de atención de alertas	Como sistema, quiero registrar quién atendió una alerta y cuándo, para mantener trazabilidad de las acciones.	3
16	US-13	Observación breve al atender una alerta	Como médico, quiero agregar una observación breve al atender una alerta, para dejar registro rápido de lo ocurrido.	2
17	US-14	Visibilidad de revisión previa por otro profesional	Como médico, quiero ver si un caso ya fue revisado por otra persona, para evitar duplicar esfuerzos.	2
18	US-17	Almacenamiento del historial del paciente	Como sistema, quiero almacenar el historial de un paciente (registros, alertas, acciones), para permitir consultas posteriores.	8
19	US-11	Historial de registros del paciente ordenado por fecha	Como médico, quiero ver el historial de registros de un paciente ordenado por fecha, para entender su evolución sin papeles dispersos.	5
20	US-21	Validación de datos básicos del paciente	Como sistema, quiero validar que los datos básicos de un paciente estén completos antes de activar su seguimiento, para asegurar información mínima confiable.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
21	US-20	Asociación de paciente con proveedor de salud	Como sistema, quiero asociar a cada paciente un proveedor de salud (si existe), para vincular la información clínica correspondiente.	3

4. Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

El diseño visual de la aplicación VitaLink sigue una estética entre lo clínico y lo confiable, esto porque va relacionado a la identidad que tiene el startup BrokerCodes y el compromiso que tenemos por ofrecer soluciones de calidad hacia el sector salud, enfocadas en el cuidado y acompañamiento de adultos mayores.

Es por esto que, en este capítulo, describiremos cada uno de los detalles y estilos que estaremos utilizando al momento de desarrollar la aplicación (siguiendo los principios UX y UI).

4.1.1. General Style Guidelines

Branding

El logo principal representa a Vitalink, una plataforma orientada al monitoreo y seguimiento de la salud de los adultos mayores. El nombre surge de la combinación de “Vital”, relacionado con los signos vitales, la salud y el bienestar, y “Link”, que representa la conexión constante entre el adulto mayor, sus familiares y los profesionales o centros de salud.

La identidad visual incorpora un ícono minimalista que combina elementos relacionados con la salud, el monitoreo y la conexión. El símbolo representa una figura humana protegida dentro de una forma inspirada en un corazón, integrando además una línea de pulso o electrocardiograma. Este recurso visual comunica de manera directa el propósito de Vitalink: cuidar, monitorear y mantener conectadas a las personas involucradas en el bienestar del adulto mayor.



Typography

La tipografía principal empleada será Arial, utilizando sus variantes Regular, SemiBold y Bold.

La elección de esta tipografía se debe principalmente a su alta legibilidad, simplicidad y compatibilidad con diferentes dispositivos tecnológicos, como ordenadores, tabletas y teléfonos móviles. Esto resulta especialmente importante para Vitalink, ya que la plataforma puede ser utilizada por adultos mayores, familiares y profesionales de la salud.

El uso de una tipografía clara y fácil de leer permitirá que la información relacionada con signos vitales, alertas, estados de salud y otros datos importantes pueda ser comprendida rápidamente.

El tamaño de letra utilizado en la aplicación seguirá la siguiente distribución:

Títulos principales: 2.25rem (36px), utilizados para encabezados principales y secciones importantes. Subtítulos: entre 1.5rem (24px) y 1.75rem (28px), utilizados para organizar las diferentes secciones de información. Texto secundario: entre 1.125rem (18px) y 1.25rem (20px), especialmente recomendado para información relevante o elementos que requieran mayor visibilidad. Cuerpo del texto: 1rem (16px), acompañado de un interlineado aproximado de 1.5 a 1.6 para facilitar la lectura. Información auxiliar: 0.875rem (14px), utilizada para etiquetas, fechas, información complementaria o textos secundarios.

La tipografía y los colores serán utilizados manteniendo un contraste adecuado entre el texto y el fondo, buscando cumplir con un ratio mínimo de 4.5:1, de acuerdo con las recomendaciones de accesibilidad WCAG 2.1 AA.

Paleta de Colores y Jerarquía Visual

1. Paleta Principal

- **Verde Vitalink (#1D9E75):** Funciona como color principal de la marca y se utiliza en botones, elementos interactivos, indicadores y componentes destacados.

2. Paleta Secundaria

- **Verde Oscuro (#0F6E56):** Se utiliza como color complementario para reforzar elementos de la interfaz y generar diferentes niveles de jerarquía visual.
- **Neutro Claro (#F8F9FB):** Funciona como base para fondos y superficies, permitiendo mantener una interfaz limpia y facilitar la lectura del contenido.

3. Colores Funcionales

- **Tonos verdes:** Se utilizan principalmente para representar estados positivos, información correcta, bienestar y confirmaciones dentro de la aplicación. Estos colores permiten comunicar visualmente información relevante sin sobrecargar la interfaz.

4. Neutrales

- **Tonos neutros:** Se utilizan para fondos, tarjetas, separadores y elementos secundarios, creando contraste con los colores principales y manteniendo una apariencia limpia y profesional.

GAMA DE 7 TONOS POR CATEGORÍA DE COLOR

	Tono 1	Tono 2	Tono 3	Tono 4	Tono 5	Tono 6	Tono 7
Primary: Verde Vitalink (#1D9E75)	#EBF7F2	#ADF0DB	#71E5C0	#30D9A3	#1D9E75	#146C50	#10372B
Secondary: Azul Profundo (#042C53)	#E6F0F9	#A3CFFB	#5EACF7	#1586F4	#0962B9	#06407A	#0C2C4B
Tertiary: Verde Oscuro (#0F6E56)	#EBF8F4	#AAF3E1	#6BEBCA	#28C2B3	#17AB85	#0F6E56	#0E392E
Neutral: Blanco Neutro (#F8FAFB)	#FFFFFF	#F8FAFB	#E2ECF1	#B8CDDA	#84A4B5	#517282	#22323A

Spacing

El sistema de spacing mantiene una estructura consistente para conseguir una interfaz ordenada, profesional y fácil de utilizar:

- **Spacing base de 0.5 rem (8 px)** para mantener consistencia y ritmo visual entre los diferentes elementos de la aplicación.
- **Padding interno de 1.5 rem a 3.75 rem (24–60 px)** en tarjetas, contenedores y secciones principales, proporcionando suficiente espacio para evitar una apariencia sobrecargada.
- **Separación entre secciones de 3.75 rem a 5 rem (60–80 px)** para establecer una jerarquía clara entre los diferentes bloques de contenido.
- **Spacing entre elementos relacionados de 0.5 rem a 1.875 rem (8–30 px)**, dependiendo de su nivel de relación y jerarquía.
- **Componentes interactivos:** Mantienen un espacio suficiente alrededor de ellos para facilitar la navegación y mejorar la experiencia de usuario.

Tono de Comunicación

La comunicación de Vitalink Professional busca transmitir profesionalismo, confianza y cercanía, utilizando un lenguaje sencillo que permita al usuario comprender rápidamente la información proporcionada.

- **Equilibrio:** Profesional pero accesible (75% formal, 25% cercano), proyectando una imagen confiable sin generar una comunicación excesivamente rígida.
- **Actitud:** Segura, clara y positiva (85% profesional, 15% entusiasta), especialmente en mensajes relacionados con acciones, resultados y mejoras.

- **Lenguaje:** Directo, claro y orientado a beneficios, evitando términos técnicos innecesarios y priorizando información que pueda ser comprendida rápidamente.
- **Voz:** Profesional, confiable y orientada al bienestar, posicionando Vitalink Professional como una herramienta que facilita la gestión y permite tomar decisiones basadas en información clara.

4.1.2. Web Style Guidelines

Esta sección describe los lineamientos visuales comunes aplicados a las diferentes vistas de la landing page de VitaLink, manteniendo una identidad visual coherente independientemente del tipo de usuario al que esté dirigida cada vista. Aunque el contenido y algunos elementos pueden adaptarse según el perfil del usuario, ambas mantienen los mismos principios de diseño en cuanto a colores, tipografía, estructura, componentes, iconografía, espaciado y tono comunicacional. La propuesta busca transmitir una imagen de tecnología aplicada a la salud, confianza, seguridad y facilidad de uso.

Botones y Elementos de Acción

- **Color principal:** Verde médico (#00694C), utilizado como color predominante para las acciones principales.
- **Estados de interacción:** Se utiliza el verde secundario (#008560) para estados hover y elementos destacados.
- **Tipografía:** Inter, con peso semibold o bold, favoreciendo una lectura clara.
- **Color del texto:** Blanco (#FFFFFF) sobre botones de color verde y gris oscuro (#191C1D) sobre botones secundarios.
- **Forma:** Esquinas redondeadas, principalmente entre 12px y 16px, manteniendo una apariencia moderna y amigable.
- **Estilo:** Los botones principales pueden incorporar sombras sutiles y transiciones para reforzar su jerarquía.
- **Tono comunicacional:** Directo, profesional y orientado a la acción, utilizando textos claros que indican al usuario qué puede realizar.

Enlaces de Navegación

- **Color:** Los enlaces utilizan tonos gris verdoso (#3D4943) y cambian al verde principal (#00694C) durante la interacción.
- **Tipografía:** Inter, principalmente con peso semibold.
- **Estilo:** Sin subrayado, con espaciado suficiente entre elementos para facilitar la navegación.
- **Jerarquía:** La navegación diferencia claramente los elementos principales de los secundarios.
- **Tono:** Claro, profesional y sencillo, permitiendo al usuario identificar rápidamente las diferentes secciones de la plataforma.

Header

- **Estructura:** Ambas vistas mantienen un encabezado superior como elemento principal de navegación e identificación de la plataforma.
- **Identidad:** El logotipo y el nombre de VitaLink se mantienen como elementos fundamentales de reconocimiento de marca.
- **Fondo:** Predominio de superficies claras, principalmente blanco (#FFFFFF) o tonos neutros muy claros.
- **Posición:** El encabezado se mantiene en la parte superior y presenta una separación visual respecto al contenido.
- **Navegación:** Incluye accesos a las principales secciones y acciones relevantes para el usuario.
- **Estilo:** Limpio, minimalista y organizado, evitando una sobrecarga de elementos.
- **Tono:** Confiable, profesional y accesible.

Estructura de las Secciones

- **Distribución:** Las diferentes vistas mantienen una estructura organizada mediante bloques de contenido claramente diferenciados.
- **Fondos:** Se combinan superficies blancas (#FFFFFF) con fondos neutros claros como #F8FAFB, #F2F4F5 y #ECEEFF para establecer separación entre secciones.
- **Espaciado:** Se utiliza un espaciado amplio entre bloques, proporcionando una experiencia visual limpia y evitando la saturación de información.
- **Contenedores:** El contenido se organiza dentro de áreas de ancho limitado para mejorar la legibilidad y mantener una composición equilibrada.
- **Jerarquía:** Cada sección presenta títulos, textos descriptivos, elementos visuales o componentes interactivos claramente diferenciados.
- **Tono:** Ordenado, profesional y fácil de comprender.

Tarjetas y Contenedores

- **Fondo:** Blanco (#FFFFFF), principalmente sobre superficies neutras.
- **Bordes:** Gris claro (#E1E3E4) para delimitar los componentes.
- **Forma:** Esquinas redondeadas, generalmente de 16px.
- **Sombras:** Sombras suaves utilizadas para generar profundidad y separar visualmente las tarjetas del fondo.
- **Contenido:** Permiten organizar información, funcionalidades, beneficios o elementos relacionados con la plataforma.
- **Estilo:** Minimalista, evitando decoraciones innecesarias y priorizando la información.
- **Tono:** Profesional, limpio y confiable.

Tipografía

- **Familia:** Inter, utilizada como tipografía principal en las diferentes vistas.
- **Títulos principales:** Tamaños grandes, aproximadamente 48px, con peso bold.
- **Títulos de sección:** Aproximadamente 32px, con peso semibold.
- **Subtítulos:** Aproximadamente 24px, con peso semibold.
- **Texto principal:** 16px, con peso regular.
- **Texto destacado:** 18px para descripciones o mensajes de mayor importancia.
- **Etiquetas:** Entre 11px y 14px, utilizando pesos medium o semibold.
- **Características:** La tipografía mantiene una jerarquía visual clara y una buena legibilidad tanto para contenidos informativos como para elementos interactivos.

Iconografía

- **Estilo:** Lineal, minimalista y funcional.
- **Sistema:** Material Symbols.
- **Uso:** Los iconos acompañan botones, tarjetas, alertas, funcionalidades y elementos de navegación.
- **Tamaño:** Se adapta según la jerarquía del componente, desde aproximadamente 18px en elementos pequeños hasta 40px o más en elementos destacados.
- **Colores:** Predominan el verde principal (#00694C), azul secundario (#416089), verde terciario (#026951) y rojo (#BA1A1A) para situaciones de alerta.
- **Tono:** Funcional y fácil de interpretar, complementando el contenido textual sin sustituirlo.

Elementos Visuales e Imágenes

- **Estilo:** Las imágenes utilizadas buscan representar el contexto tecnológico y sanitario de VitaLink.
- **Presentación:** Las imágenes se integran dentro de contenedores con bordes redondeados y sombras sutiles.

- **Composición:** Se utilizan elementos visuales junto al contenido textual para facilitar la comprensión de la propuesta de valor.
- **Interacción:** Algunos elementos visuales incorporan transiciones o movimientos sutiles para aportar dinamismo.
- **Tono:** Moderno, tecnológico y profesional, reforzando la relación entre salud y tecnología.

Alertas y Estados

- **Color de alerta:** Rojo (#BA1A1A), utilizado para representar situaciones que requieren atención.
- **Fondo:** Rojo claro (#FFDAD6) en los componentes que requieren destacar una situación crítica.
- **Iconografía:** Se emplean símbolos relacionados con notificaciones, signos vitales o situaciones de atención.
- **Uso:** Las alertas se presentan como elementos visualmente diferenciados para facilitar su identificación.
- **Tono:** Claro, preventivo e inmediato, evitando elementos visuales excesivamente agresivos.

Paleta de Colores Común

- **Verde principal (#00694C):** Identidad principal de VitaLink y acciones importantes.
- **Verde secundario (#008560):** Estados de interacción y elementos destacados.
- **Verdes claros (#68DBAE y #86F8C9):** Acentos y elementos decorativos.
- **Azul secundario (#416089):** Elementos complementarios y tecnológicos.
- **Verde terciario (#026951 y #2D8269):** Elementos asociados a salud y seguridad.
- **Blanco (#FFFFFF):** Fondos, tarjetas y superficies principales.
- **Fondo neutro (#F8FAFB, #F2F4F5 y #E0E0E0):** Diferenciación entre secciones.
- **Gris claro (#E1E3E4):** Bordes y separadores.
- **Gris verdoso (#3D4943):** Textos secundarios.
- **Gris oscuro (#191C1D):** Títulos y textos principales.
- **Rojo (#BA1A1A):** Alertas y situaciones críticas.

Espaciado y Bordes

- **Unidad base:** 8px como referencia para mantener consistencia en márgenes y separaciones.
- **Separación entre secciones:** Espacios amplios, aproximadamente 80px en secciones principales.
- **Márgenes:** Adaptados según el dispositivo, utilizando aproximadamente 40px en escritorio y 20px en dispositivos móviles.
- **Bordes:** Predominan bordes suaves y discretos.
- **Radios:** Se utilizan esquinas redondeadas en botones, tarjetas, imágenes y contenedores.
- **Objetivo:** Mantener una apariencia uniforme y facilitar la lectura visual de los contenidos.

Diseño Responsivo

- **Adaptabilidad:** Las dos vistas mantienen los mismos principios visuales independientemente del tamaño de pantalla.
- **Escritorio:** Se aprovechan distribuciones de varias columnas para organizar contenido, imágenes y componentes.
- **Dispositivos móviles:** Los elementos se reorganizan verticalmente, priorizando la legibilidad y las acciones principales.
- **Navegación:** Algunos elementos secundarios pueden ocultarse o reorganizarse para evitar saturación.
- **Objetivo:** Garantizar una experiencia consistente y funcional en diferentes dispositivos.

Tono Comunicacional General

Profesional, claro, confiable y empático. Ambas vistas utilizan un lenguaje orientado a la salud y la tecnología, buscando transmitir seguridad y confianza sin generar una percepción excesivamente técnica o compleja. La

comunicación prioriza mensajes directos, beneficios concretos y llamados a la acción fácilmente identificables.

En conjunto, los elementos comunes permiten que las diferentes vistas sean reconocidas como parte de un mismo producto digital. La consistencia en la paleta de colores, tipografía, botones, iconografía, espaciado, tarjetas, bordes y estructura visual permite que VitaLink mantenga una identidad unificada, aun cuando el contenido y las funcionalidades presentadas puedan variar según el tipo de usuario.

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems

VitaLink implementa sistemas de organización visual cuidadosamente seleccionados para estructurar el contenido de su landing page y facilitar la navegación de los usuarios:

Organización Jerárquica (Visual Hierarchy)

Se aplica en toda la estructura de la landing page para establecer diferentes niveles de importancia y guiar la atención del usuario: * **Nivel 1:** Header y navegación principal, donde se presentan el logotipo de VitaLink, las secciones principales y los botones de acción. * **Nivel 2:** Títulos y mensajes principales de cada sección, como “Flujo clínico integrado”, “Protocolo de Alerta Inteligente” y “Seguridad de grado médico”. * **Nivel 3:** Descripciones, características, beneficios y elementos secundarios que complementan la información principal.

La jerarquía se refuerza mediante tamaños tipográficos, peso de la fuente, colores, contraste, espaciado y posición de los elementos, permitiendo que el usuario identifique rápidamente la información más relevante.

Organización Secuencial (Step-by-Step)

Se utiliza principalmente en la sección “Flujo clínico integrado”, donde se presenta de manera progresiva el funcionamiento que VitaLink comunica a sus usuarios: * **Captura Continua:** Representa la recopilación de información. * **Análisis Algorítmico:** Representa el procesamiento de los datos. * **Alertas Integradas:** Representa la comunicación de posibles situaciones de riesgo.

Las tres etapas se presentan de forma consecutiva y conectadas visualmente, permitiendo comprender el concepto de funcionamiento de VitaLink sin necesidad de navegar a otra página.

Organización por Secciones

La landing page divide la información en bloques claramente diferenciados, permitiendo presentar cada aspecto del producto de forma independiente: * **Hero:** Presenta la propuesta de valor principal de VitaLink y las acciones principales. * **Flujo clínico integrado:** Explica visualmente cómo funciona el sistema. * **Protocolo de Alerta Inteligente:** Comunica las principales características relacionadas con las alertas. * **Seguridad de grado médico:** Presenta los elementos relacionados con seguridad y cumplimiento. * **Unirme como proveedor de salud:** Funciona como llamada a la acción final. * **Footer:** Agrupa información institucional, legal, contacto y enlaces adicionales.

Categorización por Tópicos

La información de la landing se agrupa según diferentes temas relacionados con la propuesta de VitaLink: * **Beneficios y propuesta de valor:** Información orientada a explicar las ventajas de VitaLink. * **Funcionamiento:** Contenido relacionado con la captura, análisis y generación de alertas. * **Seguridad:** Información sobre cifrado, cumplimiento normativo y control de acceso. * **Servicios para profesionales:** Beneficios y herramientas disponibles para proveedores de salud. * **Información complementaria:** Preguntas frecuentes, contacto y aspectos legales.

Esta categorización permite que el usuario pueda identificar rápidamente el tema de cada sección y comprender la propuesta de valor de la plataforma.

Categorización por Audiencia

La landing contempla diferentes perfiles de usuario mediante elementos de navegación y llamadas a la acción: * **Profesionales de la salud:** Cuentan con contenido orientado al monitoreo clínico, las alertas y la incorporación como proveedor. * **Pacientes:** Disponen de una vista diferenciada mediante el selector de tipo de usuario presente en el header. * **Familiares:** Se relacionan principalmente con la propuesta de acompañamiento y monitoreo preventivo presentada por VitaLink.

La combinación de estos sistemas de organización permite que la landing page presente una estructura clara y coherente, guiando al usuario desde la propuesta de valor inicial hasta la información específica y las llamadas a la acción, manteniendo una experiencia consistente entre las diferentes vistas de la misma landing page.

4.2.2. Labeling Systems

El sistema de etiquetado de VitaLink está diseñado para comunicar la propuesta de valor de la landing page de manera clara, directa y fácil de comprender. Las etiquetas utilizan un número reducido de palabras y términos relacionados con el ámbito de la salud y el monitoreo preventivo, buscando facilitar el escaneo visual y reducir la carga cognitiva de los visitantes.

Principios de Etiquetado

- **Concisión:** Se utilizan etiquetas breves y directas, generalmente de una a cuatro palabras, como “Red Médica”, “Seguridad de Datos” o “Flujo clínico integrado”.
- **Consistencia:** Se mantiene el mismo término para representar un concepto en las diferentes secciones de la landing, evitando utilizar palabras diferentes para una misma idea.
- **Familiaridad:** Se emplean términos reconocibles para los usuarios del ámbito de la salud, como “Pacientes”, “Profesionales de salud”, “Alertas” y “Seguridad”.
- **Claridad:** Las etiquetas buscan expresar directamente el contenido o la acción asociada, evitando términos técnicos innecesarios para los visitantes de la landing page.

Categorías de Etiquetas

Etiquetas de Navegación El menú principal utiliza etiquetas breves que permiten identificar rápidamente las diferentes áreas de información de la landing page: * “Ventajas Clínicas” * “Seguridad de Datos” * “Red Médica”

Estas etiquetas permiten al visitante reconocer el contenido de cada sección antes de acceder a ella.

Etiquetas para Identificación de Audiencia

La landing incorpora etiquetas para diferenciar los tipos de usuarios a los que está dirigida la propuesta: * “Profesionales de salud” * “Pacientes” * “Para Profesionales de la Salud”

Estas etiquetas permiten orientar rápidamente al visitante hacia la perspectiva que corresponde a su perfil.

Etiquetas para Secciones Informativas

Las principales secciones utilizan nombres descriptivos que resumen su contenido: * “Flujo clínico integrado” * “Protocolo de Alerta Inteligente” * “Seguridad de grado médico” * “Cumplimiento normativo total”

Estas etiquetas funcionan como encabezados y permiten identificar rápidamente el propósito de cada bloque de información.

Etiquetas para Características y Beneficios

En las secciones de contenido se utilizan etiquetas concretas para destacar las principales características comunicadas por VitaLink: * “Captura Continua” * “Análisis Algorítmico” * “Alertas Integradas” * “Cero Falsos Positivos” * “Escalamiento Multicanal” * “Contexto Histórico” * “Cifrado E2E” * “HIPAA & GDPR” * “Control de Acceso (RBAC)”

Estas etiquetas permiten identificar rápidamente cada beneficio o característica sin necesidad de leer inicialmente las descripciones completas.

Etiquetas de Acción (Call-to-Action)

Las acciones principales utilizan etiquetas orientadas directamente a la intención del usuario: * “Unirme como proveedor” * “Solicitar información técnica” * “Crear cuenta institucional”

Estas etiquetas indican de manera explícita qué acción puede realizar el visitante y funcionan como puntos de conversión dentro de la landing page.

Etiquetas para Información Institucional

En el footer se utilizan etiquetas simples para agrupar información complementaria: * “Legal” * “Contacto” * “Síguenos” * “Privacidad” * “Términos de Servicio”

Esta organización permite localizar rápidamente información secundaria sin competir visualmente con las llamadas a la acción principales.

Asociaciones entre Etiquetas

Las etiquetas se relacionan mediante diferentes recursos visuales y estructurales: * **Jerarquía tipográfica:** Los títulos de sección presentan mayor tamaño y peso que las etiquetas secundarias. * **Agrupación visual:** Las etiquetas relacionadas se colocan dentro de una misma sección o tarjeta para facilitar su asociación. * **Iconografía complementaria:** Los iconos ayudan a reforzar visualmente el significado de etiquetas como “Cifrado E2E”, “Control de Acceso”, “Alertas Integradas” y otras características. * **Color:** Se utiliza principalmente el color verde de VitaLink para destacar acciones y conceptos importantes, mientras que otros colores se emplean para diferenciar información secundaria o estados de alerta. * **Posición y espaciado:** Las etiquetas se organizan mediante espacios y agrupaciones consistentes para establecer relaciones entre títulos, descripciones, iconos y botones.

Este sistema de etiquetado permite que los visitantes de la landing page comprendan rápidamente la propuesta de VitaLink, identifiquen las principales características del servicio y reconozcan las acciones disponibles, manteniendo una comunicación visual consistente entre las diferentes vistas de la landing page.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

SEO Tags y Meta Tags

VitaLink implementará una estrategia de SEO y etiquetado web orientada a mejorar la visibilidad del producto en motores de búsqueda y facilitar una correcta identificación de sus contenidos. Los valores de las etiquetas se definirán de acuerdo con el propósito de cada experiencia: **Landing Page (sitio web estático)** y **Web Application**.

Landing Page (Sitio Web Estático)

La Landing Page tendrá como objetivo presentar VitaLink, comunicar su propuesta de valor y captar principalmente a profesionales e instituciones del sector salud. Por ello, las etiquetas estarán orientadas a conceptos como monitoreo preventivo, seguimiento de pacientes, alertas de salud y tecnología aplicada al ámbito clínico.

Tags principales

```
<title>VitaLink | Monitoreo Preventivo para Profesionales de la Salud</title>
```

```
<meta name="description" content="VitaLink facilita el monitoreo preventivo de pacientes mediante datos">
```

```
<meta name="keywords" content="VitaLink, monitoreo preventivo, monitoreo de pacientes, seguimiento de pacientes">
```

```
<meta name="author" content="CodeBrokers">
```

El <title> permitirá identificar claramente el producto y su orientación hacia los profesionales de la salud. La descripción resumirá la propuesta de valor de VitaLink para mejorar su representación en los resultados de búsqueda. Las palabras clave estarán relacionadas directamente con los conceptos utilizados en la Landing Page, evitando incorporar términos que no representen el propósito del producto.

Tags de viewport y responsividad

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

Estas etiquetas permitirán que la Landing Page se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, manteniendo la experiencia responsiva definida para VitaLink.

Open Graph y Social Media Tags

Para mejorar la presentación de VitaLink cuando la Landing Page sea compartida en redes sociales o plataformas de mensajería, se considerará la implementación de etiquetas Open Graph:

```
<meta property="og:title" content="VitaLink | Monitoreo Preventivo para Profesionales de la Salud">
```

```
<meta property="og:description" content="Monitoreo preventivo, alertas inteligentes y datos continuos para profesionales de la salud">
```

```
<meta property="og:image" content="[URL de la imagen oficial de VitaLink]">
```

```
<meta property="og:url" content="[URL oficial de VitaLink]">
```

```
<meta property="og:type" content="website">
```

```
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
```

La imagen utilizada deberá corresponder a un recurso gráfico oficial de VitaLink, manteniendo la identidad visual de la marca.

Optimización de la Estructura de la Landing Page

La Landing Page contará con una estructura semántica que facilite tanto la navegación de los usuarios como la interpretación del contenido por parte de los motores de búsqueda.

Se considerará:

- **Jerarquía de encabezados:** utilización de un único h1 para la propuesta de valor principal y encabezados h2 y h3 para organizar las diferentes secciones y contenidos.
- **Identificación semántica de secciones:** cada sección podrá contar con identificadores que faciliten la navegación mediante enlaces internos, por ejemplo #ventajas-clinicas, #seguridad-datos, #red-medica y #faq, en concordancia con las secciones de navegación planteadas en la Landing Page.

- **Atributos alt descriptivos:** las imágenes deberán contar con textos alternativos relacionados con su contenido. Por ejemplo, para la imagen del dashboard clínico se podrá utilizar:

```
<img alt="Dashboard clínico de VitaLink para monitoreo de pacientes">
```

- **Contenido relevante:** se utilizarán de manera natural términos relacionados con el monitoreo preventivo, alertas inteligentes, pacientes y profesionales de la salud, evitando la repetición excesiva de palabras clave.
- **Datos estructurados:** a futuro se podrá incorporar Schema.org para representar información relevante de VitaLink como producto, organización o servicio, siempre que corresponda con la información definitiva publicada.

Web Application

La Web Application tendrá un objetivo diferente a la Landing Page, ya que estará orientada a usuarios autenticados y a la gestión y visualización de información dentro de la plataforma. Por este motivo, sus etiquetas estarán enfocadas en identificar claramente la aplicación y sus diferentes vistas.

Tags principales

```
<title>VitaLink | Plataforma de Monitoreo de Salud</title>
```

```
<meta name="description" content="Plataforma VitaLink para el seguimiento preventivo de pacientes, visu
```

```
<meta name="keywords" content="VitaLink, plataforma de salud, monitoreo de pacientes, seguimiento de sa
```

```
<meta name="author" content="CodeBrokers">
```

En la Web Application, el contenido SEO tendrá una función principalmente descriptiva y de identificación, debido a que gran parte de la información estará disponible únicamente para usuarios con acceso a la plataforma.

Para las diferentes vistas de la aplicación se podrán utilizar títulos específicos manteniendo la identidad de VitaLink, por ejemplo:

```
<title>Dashboard | VitaLink</title>
```

```
<title>Pacientes | VitaLink</title>
```

```
<title>Alertas | VitaLink</title>
```

```
<title>Perfil | VitaLink</title>
```

La implementación de estos SEO Tags y Meta Tags permitirá mantener una identificación consistente de VitaLink tanto en su **Landing Page como en su Web Application**, diferenciando el propósito de cada experiencia. La Landing Page estará enfocada principalmente en la presentación del producto, posicionamiento y captación de usuarios, mientras que la Web Application estará orientada al acceso y uso de las funcionalidades de la plataforma.

4.2.4. Searching Systems

En el Landing Page no se implementa un sistema de búsqueda, dado que el volumen de contenido es reducido y la navegación secuencial es suficiente para que el visitante encuentre la información que necesita.

4.2.5. Navigation Systems

El sistema de navegación de **VitaLink** está diseñado para facilitar el acceso a las funcionalidades e información más importantes de la plataforma, considerando las necesidades tanto de familiares y pacientes

como de profesionales de la salud.

En el **Landing Page**, la navegación es lineal con un **navbar fijo** en la parte superior que contiene anclas a las secciones principales de la página, enfocadas en explicar cómo funciona el monitoreo, el sistema de alertas, la seguridad de los datos y las preguntas frecuentes. En mobile, el navbar colapsa en un menú hamburguesa.

El selector de perfil permite cambiar entre **Familiares/Pacientes** y **Profesionales de salud**, adaptando el contenido y las acciones principales según el tipo de usuario, pero manteniendo una estructura de navegación unificada. Los **call to action** del Landing Page redirigen al usuario hacia la acción correspondiente: el CTA para familiares o pacientes permite comenzar el proceso de uso de VitaLink, mientras que el CTA para profesionales de salud permite iniciar el proceso para unirse como proveedor.

4.3. Landing Page UI Design

La propuesta de interfaz de usuario (UI) para la Landing Page de VitaLink traduce los lineamientos de arquitectura de información y el sistema de diseño establecidos previamente. El diseño se enfoca en guiar al visitante de manera intuitiva a través de la propuesta de valor, destacando las soluciones orientadas tanto a los profesionales de la salud como a los familiares cuidadores, asegurando una experiencia visual limpia, accesible y coherente en cualquier dispositivo.

4.3.1. Landing Page Wireframe

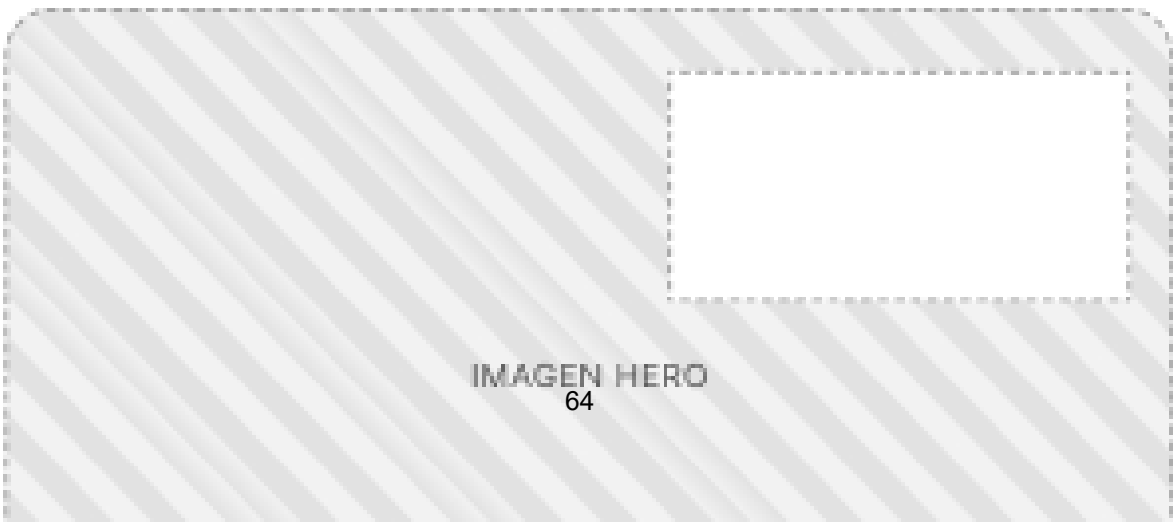
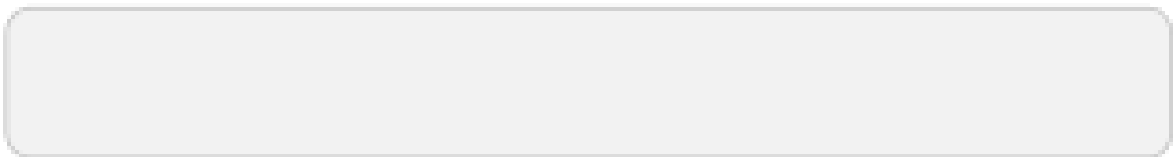
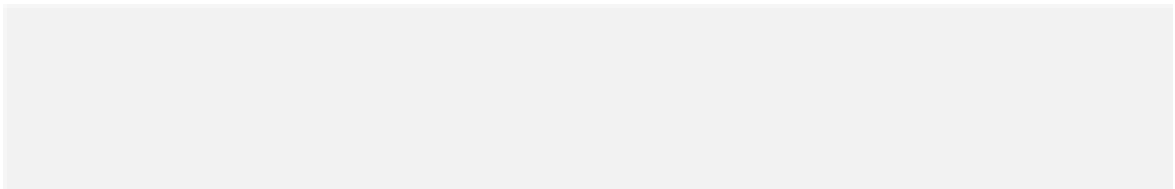
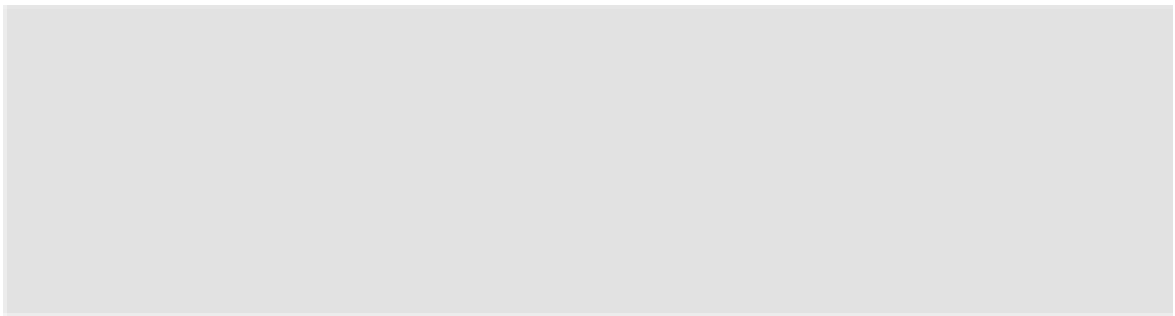
Los wireframes representan la estructura esquelética inicial de la Landing Page, priorizando la jerarquía de contenido y la distribución de los componentes por encima de los detalles estéticos. En esta fase se estructuraron las secciones principales (Hero, Flujo Clínico/Pilares, Planes y Tarifas, Seguridad y Llamados a la Acción) aplicando principios de diseño centrado en el usuario y accesibilidad (a11y).

- **Wireframe Desktop Web Browser:** Distribución en múltiples columnas para aprovechar el espacio horizontal, organizando la información mediante bloques diferenciados por fondos neutros y contenedores estructurados.





- **Wireframe Mobile Web Browser:** Reorganización vertical de los componentes, adaptando el menú de navegación a un formato de tipo hamburguesa y apilando las tarjetas de contenido para asegurar una lectura fluida en pantallas reducidas.



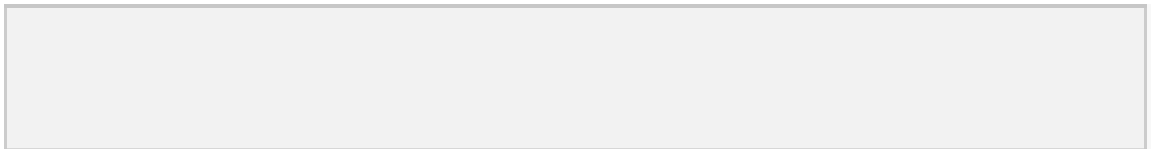
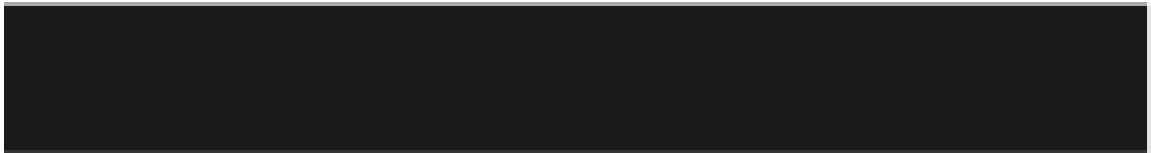
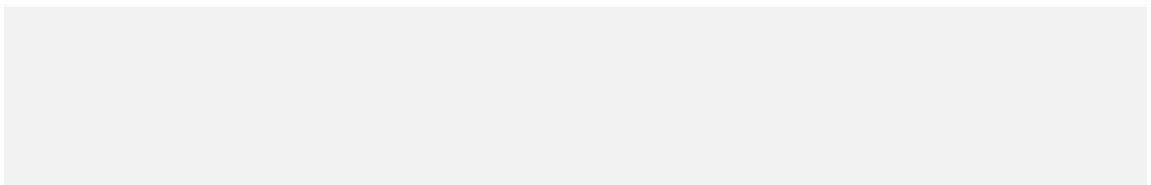
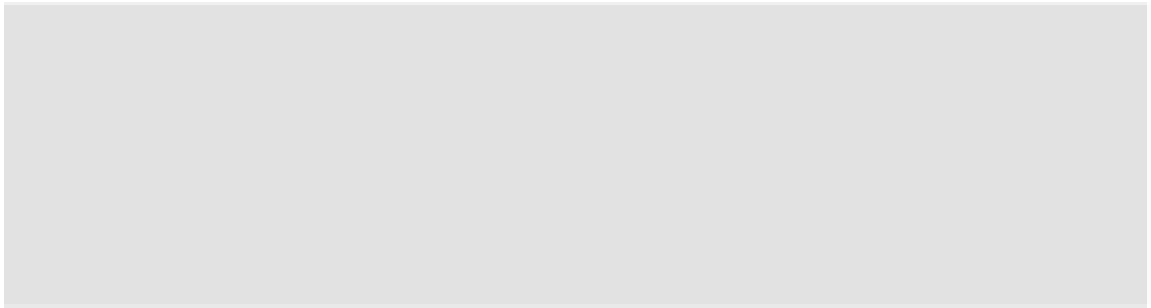
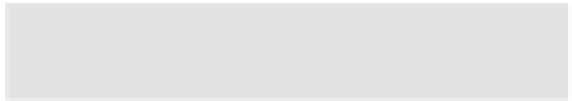
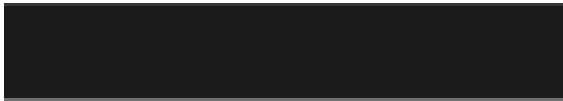
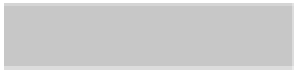


IMAGEN HERO

4.3.2. Landing Page Mock-up

Los mockups de la Landing Page reflejan la alta fidelidad visual del producto, aplicando rigurosamente el Design System de VitaLink. Esto incluye el uso de la paleta de colores corporativa (Verde Médico como tono principal), la tipografía estandarizada, el sistema de espaciado basado en unidades de 8px, la iconografía lineal y componentes con esquinas redondeadas. Todo ello busca transmitir una imagen de tecnología sanitaria moderna, segura y de alta confianza.

- **Mock-up Desktop Web Browser:** Presenta la interfaz completa con la aplicación de la identidad visual de la marca, contrastes óptimos para cumplimiento WCAG y mockups visuales del producto integrado.

La tranquilidad de saber que tus padres están bien, sin interrumpir su día.

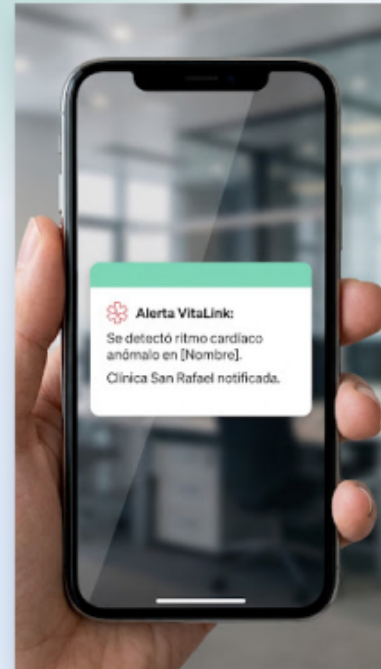
Monitoreo automático de signos vitales que avisa a la familia y a la clínica si algo no está normal. Sin depender de que alguien se acuerde de avisar.

Conocer cómo funciona

Crear cuenta



Conectando a más de 10,000 familias y clínicas.



Un ecosistema conectado, sin esfuerzo

Cuatro pilares fundamentales que garantizan la seguridad continua y la comunicación fluida entre el paciente, la familia y los profesionales de la salud.



Sensor Activo

El adulto mayor usa un sensor discreto o una aplicación simple en su dispositivo habitual.



Tiempo Real

Los datos se recopilan y analizan 24/7 de forma automática, identificando patrones sutiles.



Alerta Inmediata

Si hay una anomalía detectada, se avisa a la clínica y familia al instante de manera coordinada.



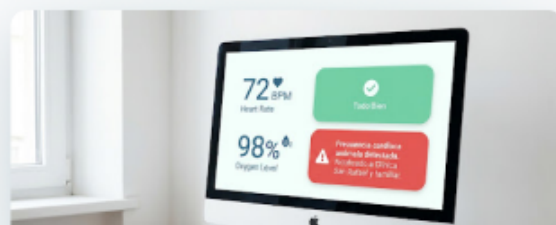
Estado Compartido

Todos ven el mismo estado actualizado, eliminando la ansiedad y las llamadas constantes de verificación.

Monitoreo profesional en tu bolsillo.

Visualiza el estado de salud de tus seres queridos con claridad profesional. Una interfaz diseñada para reducir la ansiedad, destacando solo lo importante de un vistazo rápido.

67





Flujo
Clínico

Protocolo de
Alertas

Planes

Seguridad

Profesionales
de salud

Pacientes

Unirme como
proveedor



Optimice el seguimiento preventivo con monitoreo de precisión 24/7.

Reduzca reingresos hospitalarios y mejore el control de pacientes crónicos con alertas en tiempo real integradas a su flujo clínico. Datos continuos, confiables y accionables directamente en su dashboard.

Unirme como proveedor →

Solicitar información técnica



Flujo clínico integrado

Un sistema diseñado para minimizar la carga cognitiva del profesional médico, entregando información precisa exactamente cuando se requiere intervención.



FASE 1

Captura Continua

Los biosensores del paciente recopilan métricas vitales (HR, SpO2, HRV) 24/7 de forma pasiva, transmitiendo datos cifrados a nuestra nube médica.



FASE 2

Análisis Algorítmico

Nuestros algoritmos establecen basales personalizados y detectan anomalías estadísticamente significativas antes de que los síntomas se agraven.



FASE 3

Alertas Integradas

Las notificaciones de desviación se envían inmediatamente a la clínica y a los familiares designados, permitiendo intervención temprana.



Protocolo de Alerta Inteligente

El sistema no solo notifica, contextualiza. Cuando los parámetros de un paciente salen de su rango seguro, Vitalink despliega una alerta estratificada.

- Cero Falsos Positivos**
Filtros de artefactos de movimiento y validación cruzada de sensores para evitar fatiga por alarmas.
- Escalamiento Multicanal**
Notificaciones simultáneas vía SMS, App PWA y Dashboard clínico según la gravedad configurada.
- Contexto Histórico**
Cada alerta incluye una ventana de 2 horas previas de datos vitales para evaluación retrospectiva inmediata.

- **Mock-up Mobile Web Browser:** Muestra la adaptación responsive de la interfaz a dispositivos móviles, manteniendo la consistencia de marca, legibilidad de textos y accesibilidad de los botones de acción (CTAs).

[Familiares](#)[Profesionales de salud](#)

La tranquilidad de saber que tus padres están bien, **sin interrumpir su día.**

Monitoreo automático de signos vitales que avisa a la familia y a la clínica si algo no está normal. Sin depender de que alguien se acuerde de avisar.

[Crear cuenta](#)[Conocer cómo funciona](#)

Alerta VitaLink

Se detectó ritmo cardíaco anómalo en [Mentec], Clínica

[Profesionales de salud](#)[Pacientes](#)

Optimice el seguimiento preventivo con monitoreo de precisión 24/7.

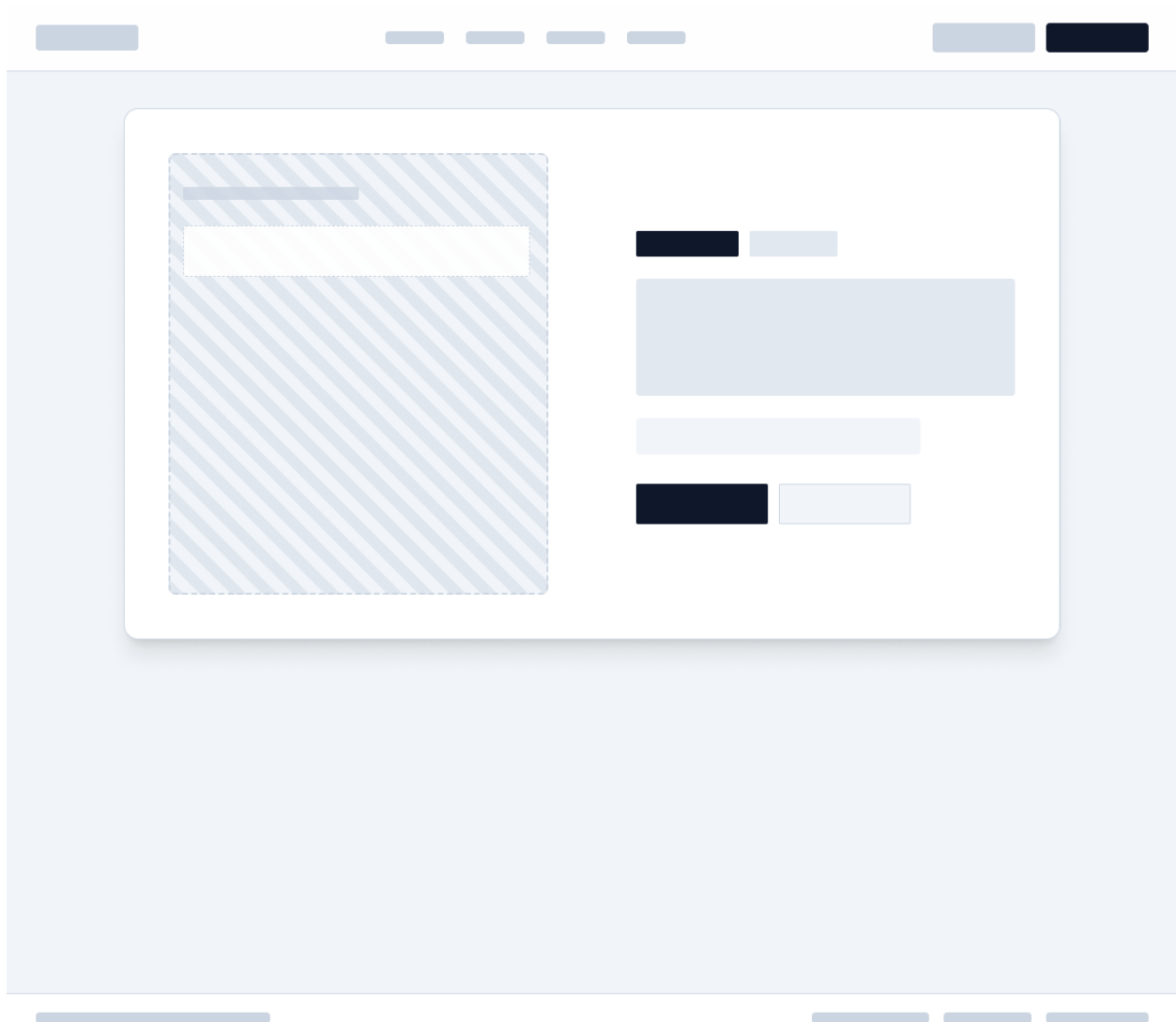
Reduzca reingresos hospitalarios y mejore el control de pacientes crónicos con alertas en tiempo real integradas a su flujo clínico.

[Unirme como proveedor →](#)[Solicitar información técnica](#)

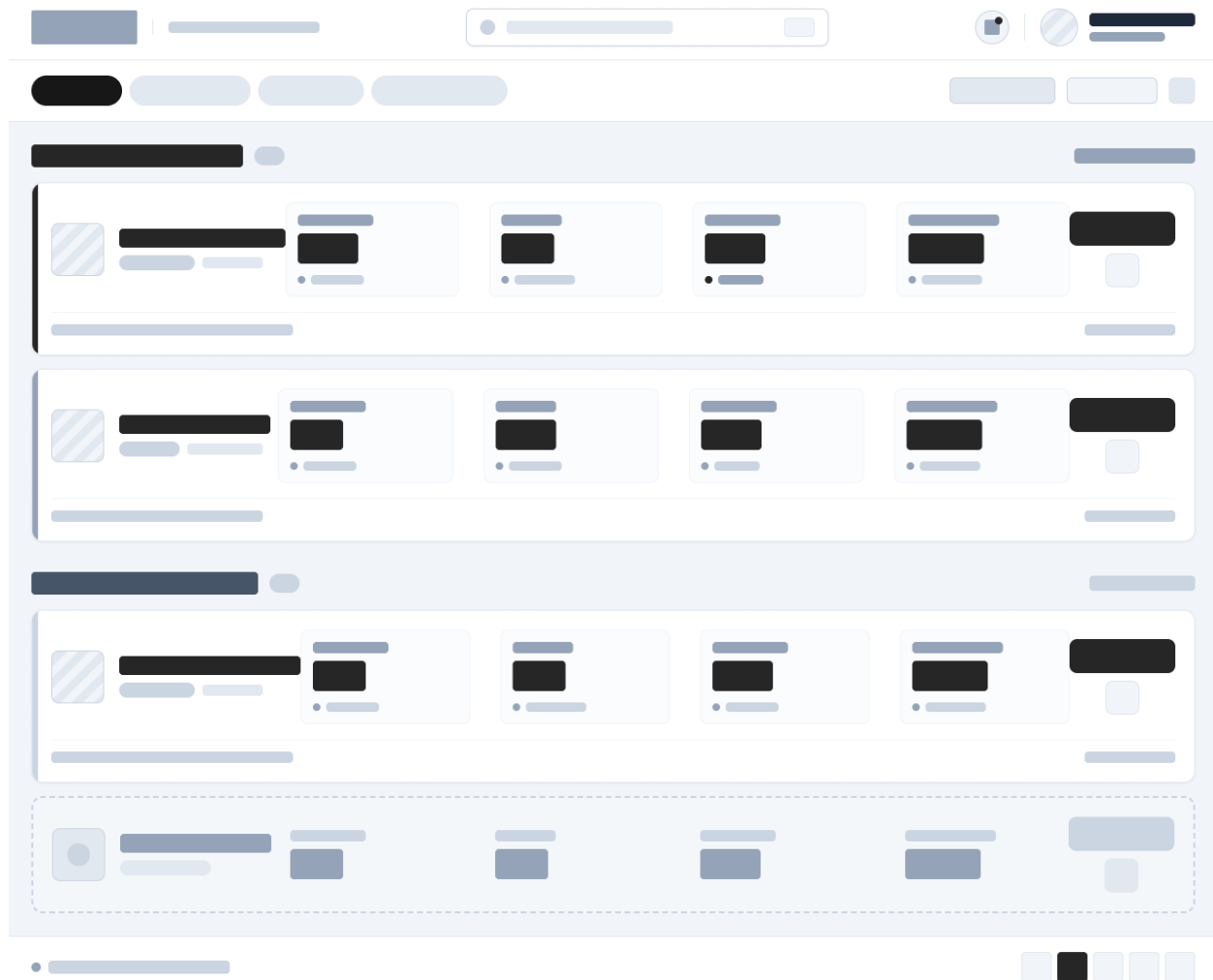
4.4 Web Applications UX/UI Design

4.4.1. Web Applications Wireframes

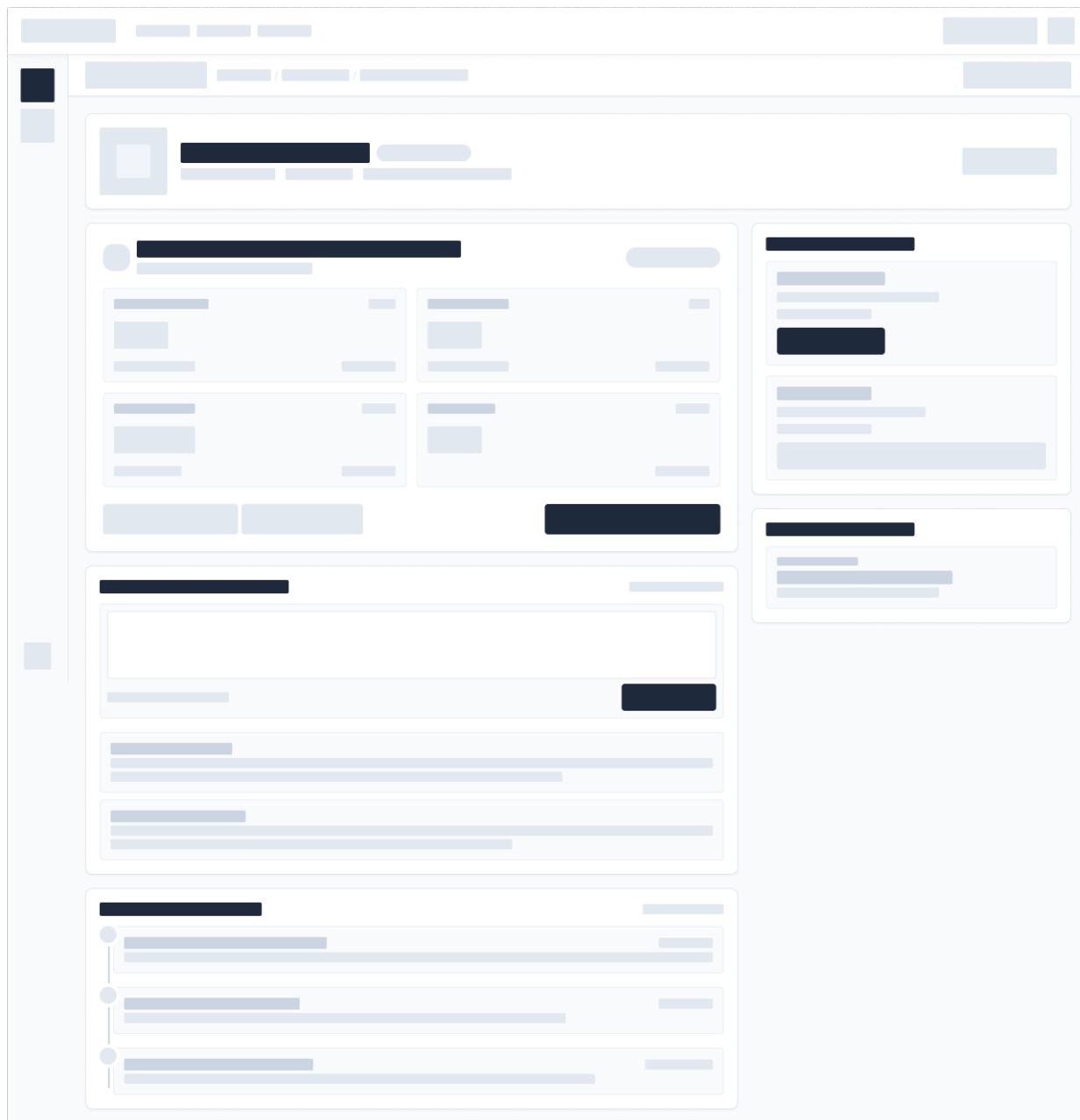
Vista Medico IniciarSesion-Wireframe



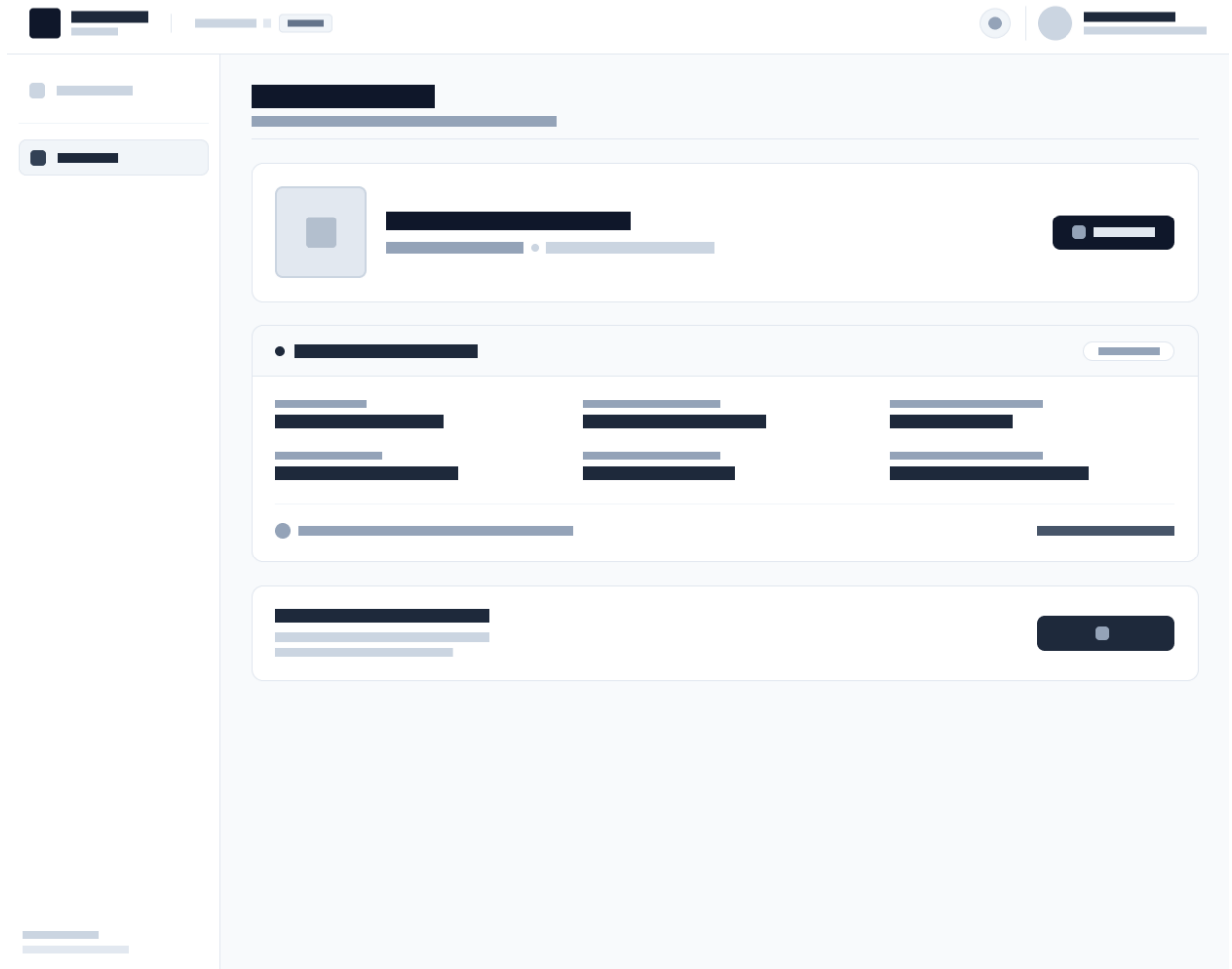
Dashboard-Wireframe



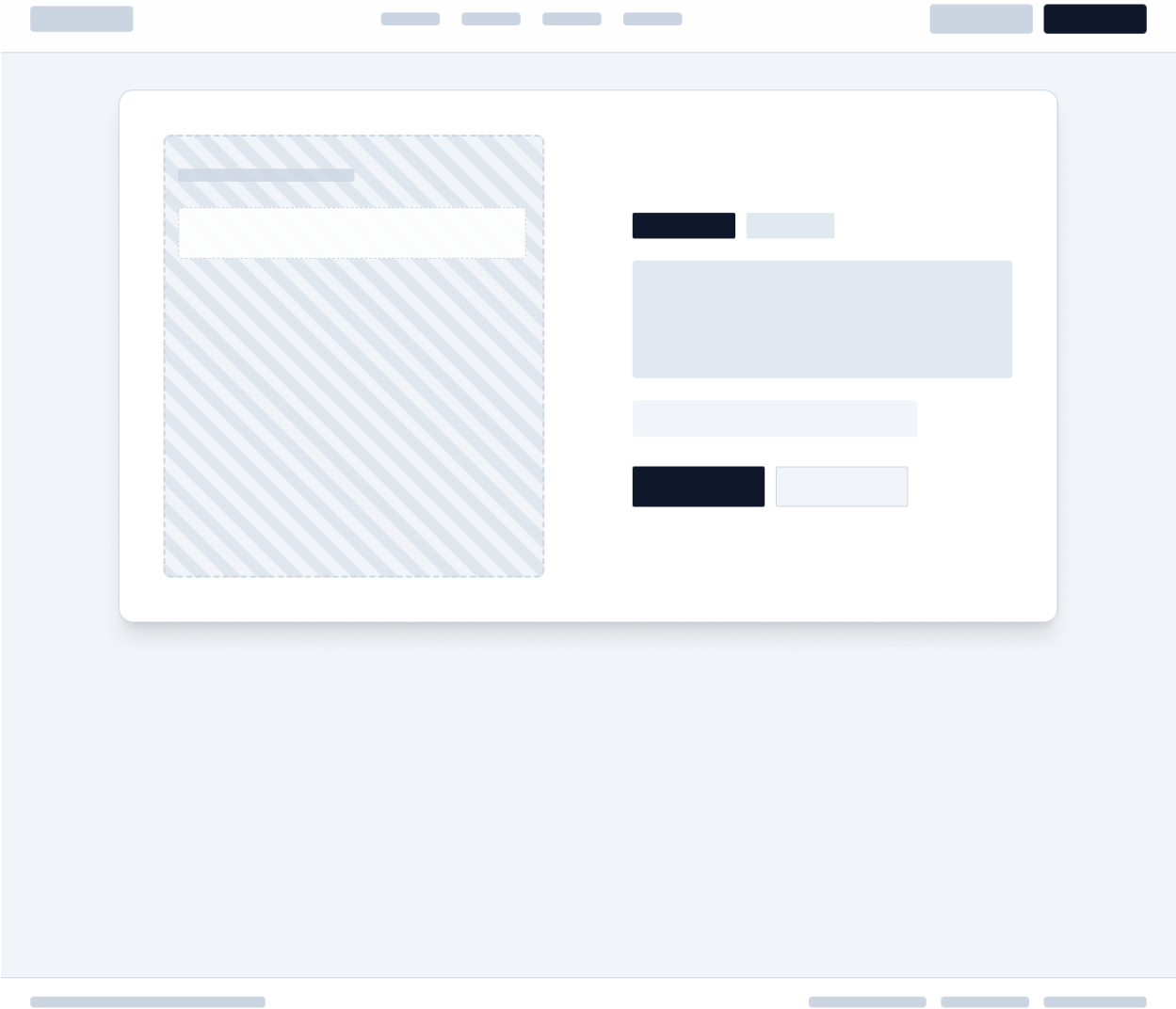
PerfilPaciente-Wireframe



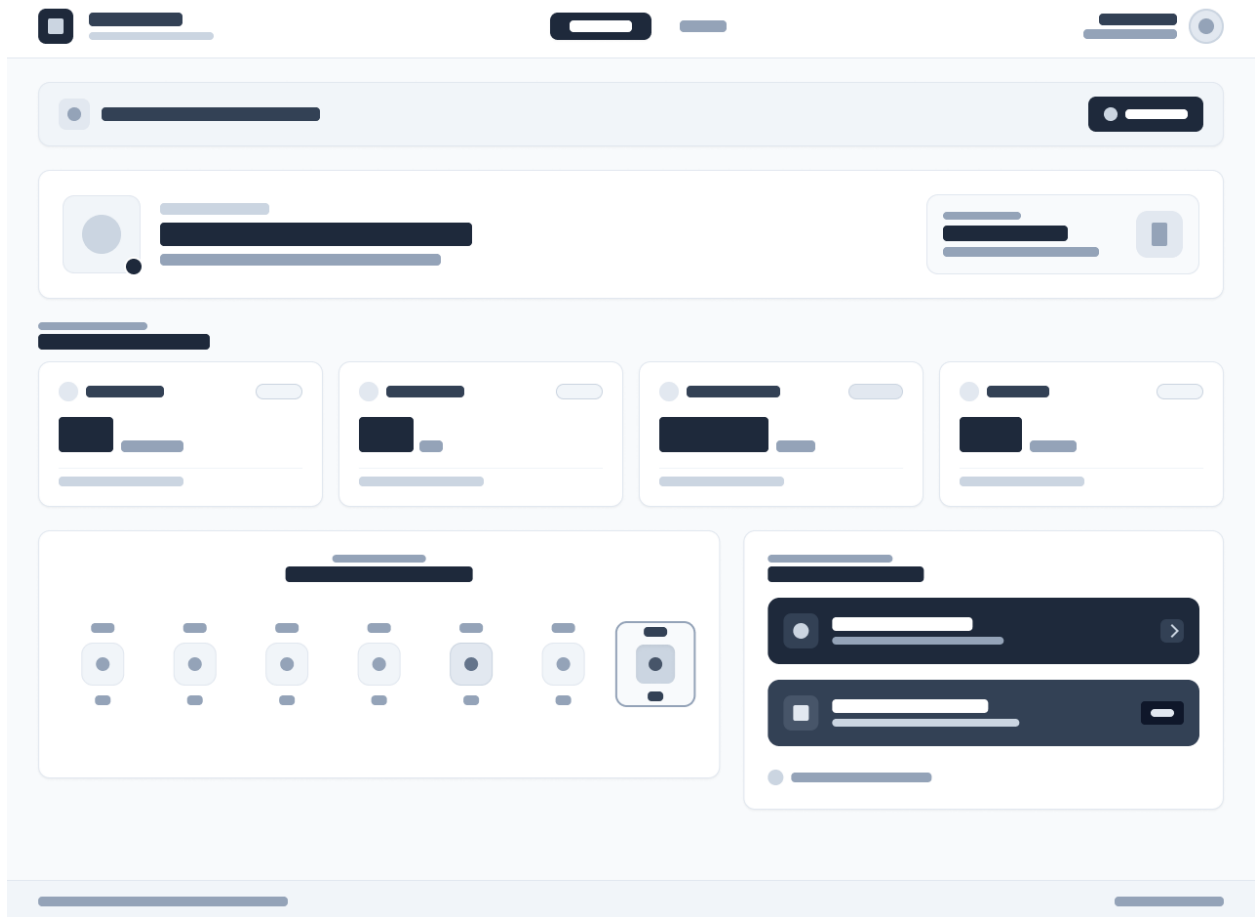
PerfilMedico-Wireframe



Vista Familiar
InciarSesion-Wireframe



DashboardFamiliar-Wireframe



PerfilPaciente-Wireframe



PerfilFamiliar-Wireframe



4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

4.4.3 .Web Applications Mock-ups

Vista- Medico

IniciarSesion-MockUp



VitaLink

MONITOREO REMOTO BIOMÉTRICO

Acceso unificado y seguro para profesionales de la salud y redes de cuidado familiar. Detección temprana y telemetría continua para adultos mayores.

Iniciar sesión

Introduce tus credenciales autorizadas para acceder a la plataforma.

CORREO ELECTRÓNICO

 dra.mendoza@vitalink.salud

CONTRASEÑA

 ContraseñaSegura2025



Ingresar a VitaLink →

¿No tienes una cuenta activa en el sistema?

[Solicitar acceso clínico o familiar](#) 

VitaLink
 MONITOREO REMOTO
 BIOMÉTRICO

Dr. Alejandro Mendoza
 Cardiología & Geriatria
 Clínica

Paciente

TRIAGE:
 Todos 28
Critico / Urgente 3
Moderado / Alerta 5
Estable / Normal 12

FLUJO:
 Pendientes (6)
Atendidas hoy (10)

Grupo Crítico (3 Pacientes en Alerta Roja)

Carmen Morales de la Vega (78 años)
CRÍTICO

FRECUENCIA CARDÍACA
134 bpm
 >100 Taquicardia Norm: 60-100

OXÍGENO (SPO2)
88%
 <90% Hipoxia crítica Norm: ≥95%

GLUCOSA
124 mg/dL
 En rango Norm: 70-140

PRESIÓN ARTERIAL
165/102 mmHg
 Crisis HTA Norm: <120/80

HAZ CLIC PARA VER HISTORIAL BIOMÉTRICO Y FICHA MÉDICA
 ID: MED-7819-CH

Ernesto Valdés Ramos (84 años)
CRÍTICO

FRECUENCIA CARDÍACA
118 bpm
 >100 Taquicardia Norm: 60-100

OXÍGENO (SPO2)
91%
 Hipoxia moderada Norm: ≥95%

GLUCOSA
115 mg/dL
 En rango Norm: 70-140

PRESIÓN ARTERIAL
145/92 mmHg
 HTA Grado 2 Norm: <120/80

HAZ CLIC PARA VER HISTORIAL BIOMÉTRICO Y FICHA MÉDICA
 ID: MED-8402-EV

Rosaura Benítez Cruz (81 años)
CRÍTICO

FRECUENCIA CARDÍACA
122 bpm
 >100 Taquicardia Norm: 60-100

OXÍGENO (SPO2)
94%
 Alerta leve Norm: ≥95%

GLUCOSA
108 mg/dL
 En rango Norm: 70-140

PRESIÓN ARTERIAL
138/88 mmHg
 Pre-HTA Norm: <120/80

HAZ CLIC PARA VER HISTORIAL BIOMÉTRICO Y FICHA MÉDICA
 ID: MED-8144-RB

Grupo Moderado (5 Pacientes en Observación)

Donato Silva Prado (76 años)
MODERADO

FRECUENCIA CARDÍACA
78 bpm
 Normal Norm: 60-100

OXÍGENO (SPO2)
93%
 Alerta leve Norm: ≥95%

GLUCOSA
210 mg/dL
 >180 Hiperglucemia Norm: 70-140

PRESIÓN ARTERIAL
130/82 mmHg
 Límite Norm: <120/80

HAZ CLIC PARA VER HISTORIAL BIOMÉTRICO Y FICHA MÉDICA
 ID: MED-7622-DS

Beatriz Loyola Méndez (82 años)
MODERADO

FRECUENCIA CARDÍACA
48 bpm
 <50 Bradicardia Norm: 60-100

OXÍGENO (SPO2)
96%
 Normal Norm: ≥95%

GLUCOSA
98 mg/dL
 En rango Norm: 70-140

PRESIÓN ARTERIAL
118/74 mmHg
 Óptima Norm: <120/80

HAZ CLIC PARA VER HISTORIAL BIOMÉTRICO Y FICHA MÉDICA
 ID: MED-8219-BL

PerfilPaciente-Mockup

81



Portal Clínico / **Mi Perfil**

Dr. Alejandro Mendoza
Cardiología & Geriatría Clínica

Pacientes

Mi Perfil

Mi Perfil Médico

Gestione su acreditación clínica, credenciales de telemetría y seguridad de la cuenta.

Dr. Alejandro Mendoza Carrillo
Cardiología & Geriatría Clínica · Facultativo Especialista de Área

DATOS PERSONALES Y COLEGIACIÓN

Modo Solo Lectura

NOMBRE COMPLETO	CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL	TELÉFONO CORPORATIVO / URGENCIAS
Dr. Alejandro Mendoza Carrillo	a.mendoza@vitalink-health.es	+34 628 449 812
ESPECIALIDAD PRIMARIA	NÚMERO DE COLEGIATURA MÉDICA	CENTRO DE SALUD / HOSPITAL ADSCRITO
Cardiología Clínica (Subesp. Geriatría)	28-2849201 (Ilustre Colegio de Madrid)	Hospital Univ. Sanitas La Moraleja & C.S. Tetuán

[Actualizar información profesional →](#)

Eliminar definitivamente mi cuenta de médico

Esta acción es **permanente e irreversible**. Su acceso a la plataforma VitaLink quedará revocado. De acuerdo con el protocolo médico, los historiales y telemetrías de los pacientes monitoreados serán transferidos automáticamente al jefe del servicio de Cardiología para garantizar la continuidad asistencial.

VitaLink RPM v2.4
Cumple HIPAA / RGPD Salud

VistaFamiliar
IniciarSesion-MockUp



VitaLink

MONITOREO REMOTO BIOMÉTRICO

Acceso unificado y seguro para profesionales de la salud y redes de cuidado familiar. Detección temprana y telemetría continua para adultos mayores.

Iniciar sesión

Introduce tus credenciales autorizadas para acceder a la plataforma.

CORREO ELECTRÓNICO

 dra.mendoza@vitalink.salud

CONTRASEÑA

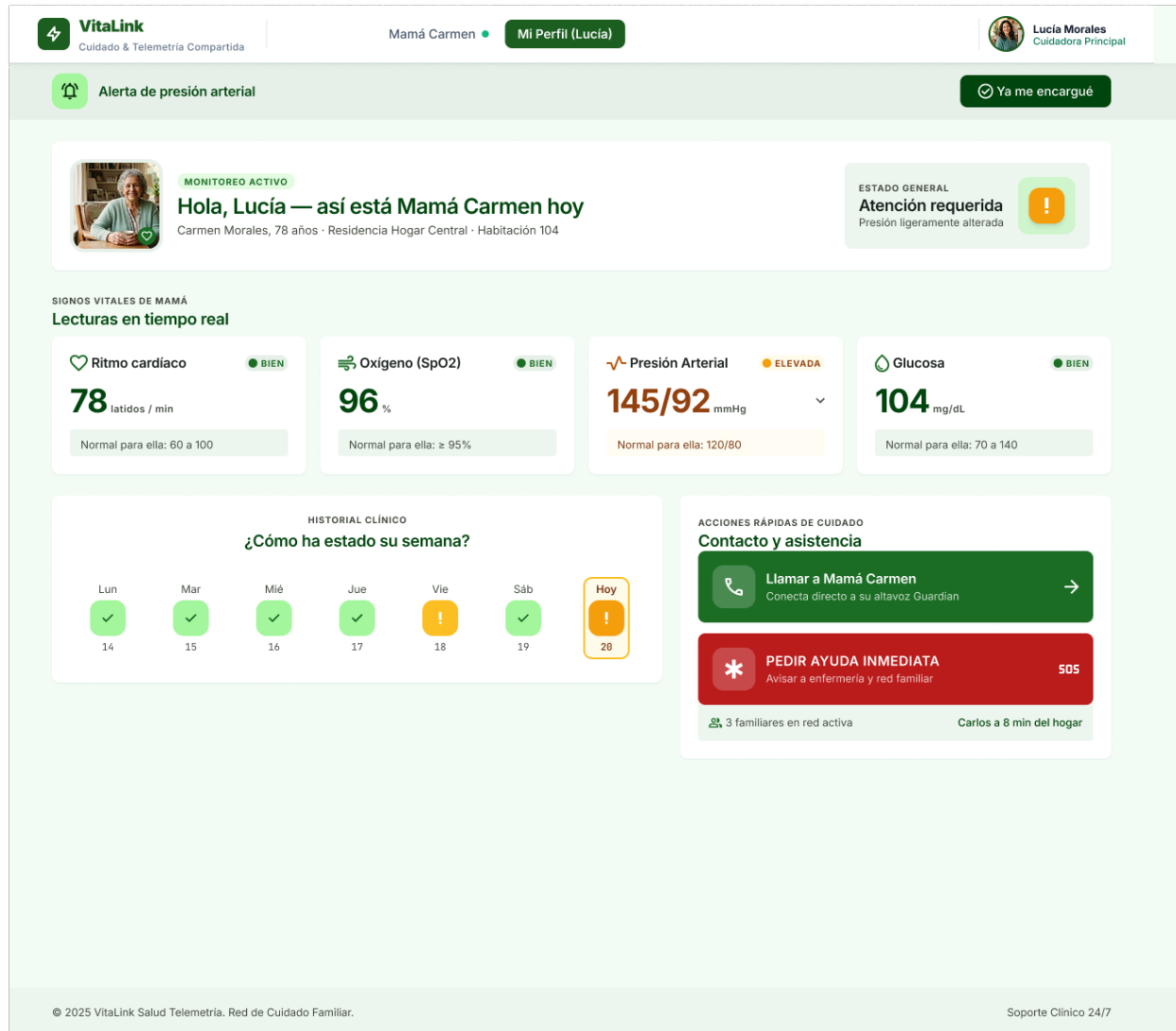
 ContraseñaSegura2025



Ingresar a VitaLink →

¿No tienes una cuenta activa en el sistema?

Solicitar acceso clínico o familiar [↗](#)



Perfil-AdultoMayor-Mockup

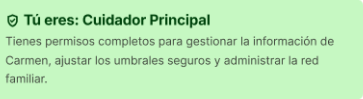

VitaLink
Cuidado & Telemetría Compartida

Mamá Carmen
Perfil Lucía


Lucía Morales
Cuidadora Principal



Carmen Morales de la Vega
78 años




Datos de Mamá Carmen
Expediente biométrico para servicios de emergencia y clínica

Editar datos

NOMBRE COMPLETO
Carmen Morales de la Vega

FECHA DE NACIMIENTO
14 de Mayo, 1946 (78 años)

DIRECCIÓN HABITUAL DE RESIDENCIA
Av. Magnolia 420, Depto 104, Col. Del Valle, CP 03100

CENTRO DE SALUD ASIGNADO & ESPECIALISTA
 **Clinica Médica Los Olivos - Geriatria Integral (Dr. Alejandro Mendoza)**

 **Rangos normales de referencia (Prescripción médica)**
La pulsera Guardian alerta a toda la familia conectada en tiempo real si las lecturas se desvían de estos parámetros seguros:

RITMO CARDÍACO
60 - 100
lpm

OXÍGENO (SPO2)
≥ 95
% sat

PRESIÓN ARTERIAL
120 / 80
mmHg

GLUCOSA AYUNAS
70 - 140
mg/dL


Mis Datos de Contacto
Tu vía directa de recepción de alarmas

Editar

NOMBRE REGISTRADO
Lucía Morales (Hija)

TELÉFONO DE EMERGENCIA
+52 (55) 8492-3011

CORREO ELECTRÓNICO
lucia.morales@vitalink.salud

Familia Conectada
3 cuidadores en la red de Doña Carmen

Agrega

LM
Lucía Morales
Principal

Hija - Gestión total y llamadas SOS inmediatas

CM
Carlos Morales
Secundario

Hijo - Avisos de urgencia y caídas

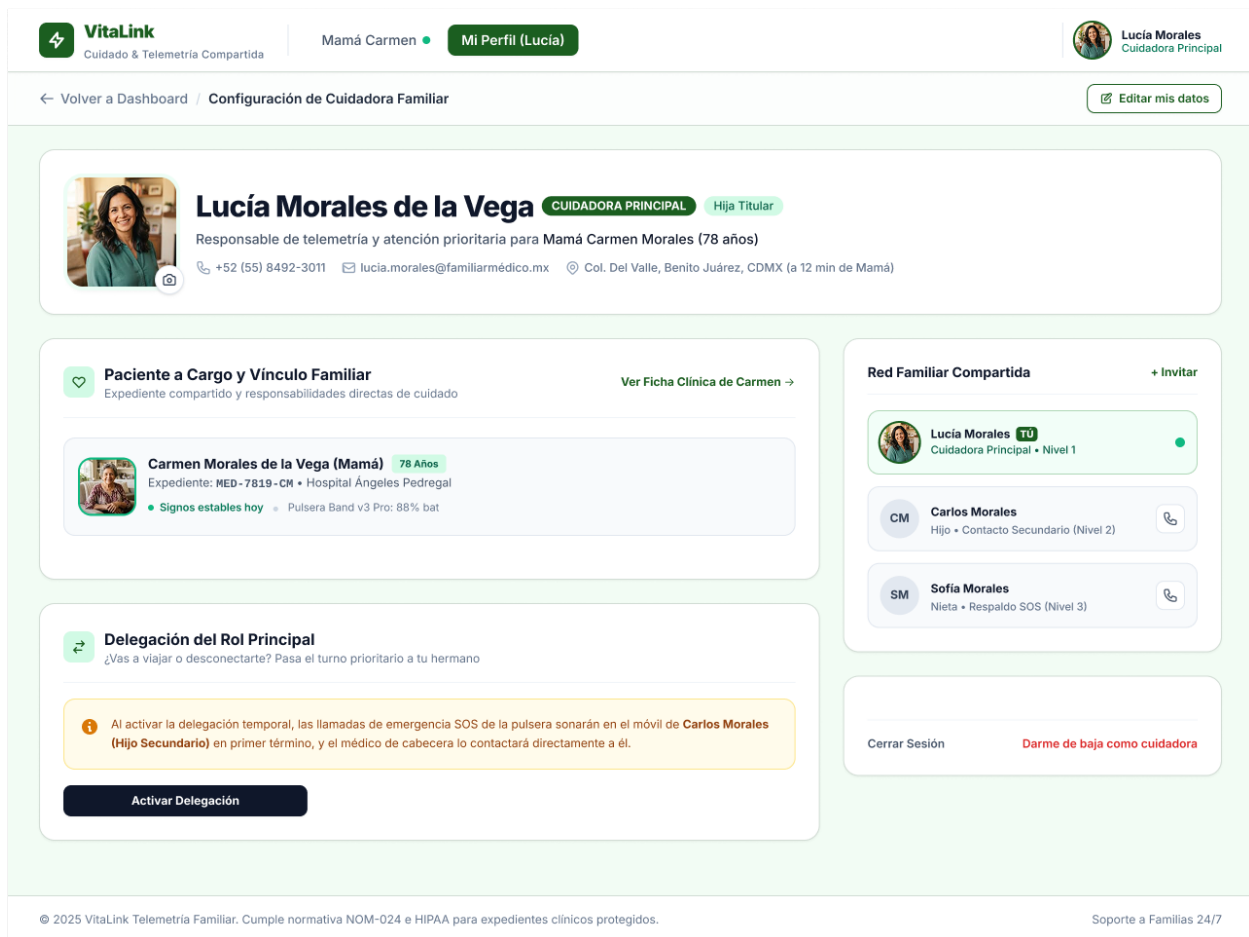
SM
Sofía Morales
Secundario

Nieta - Resumen matutino y seguimiento

Cerrar sesión en este equipo

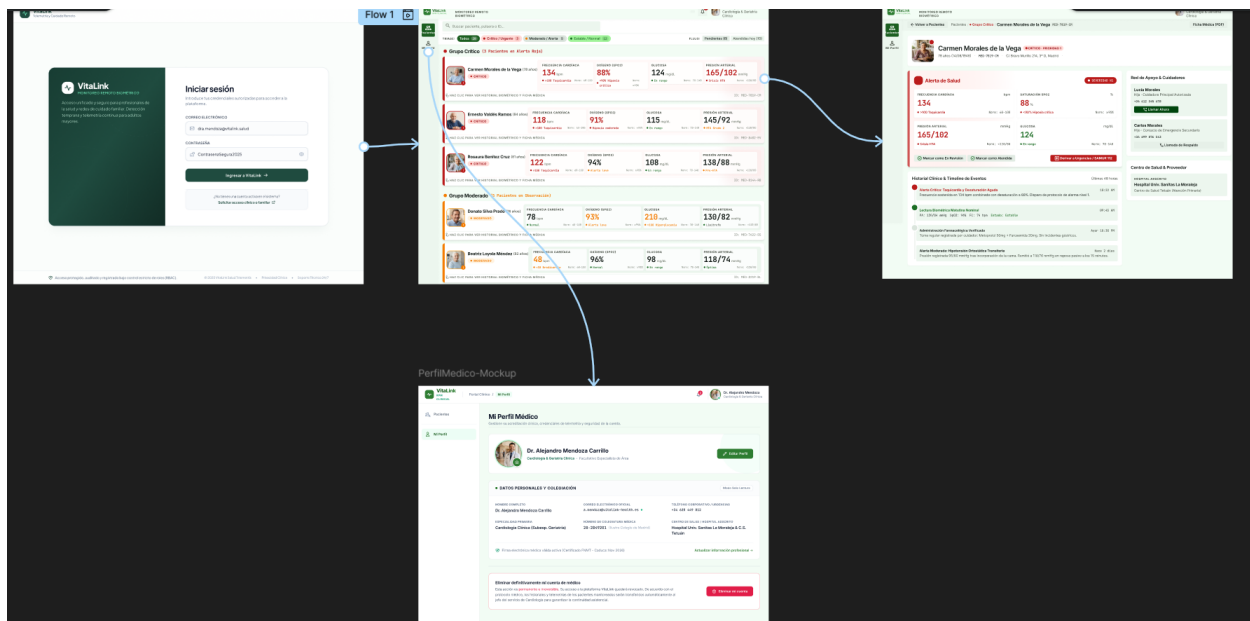
© 2024 VitaLink Telemetría S.L. Todos los derechos reservados.

Perfil-Familiar-Mockup

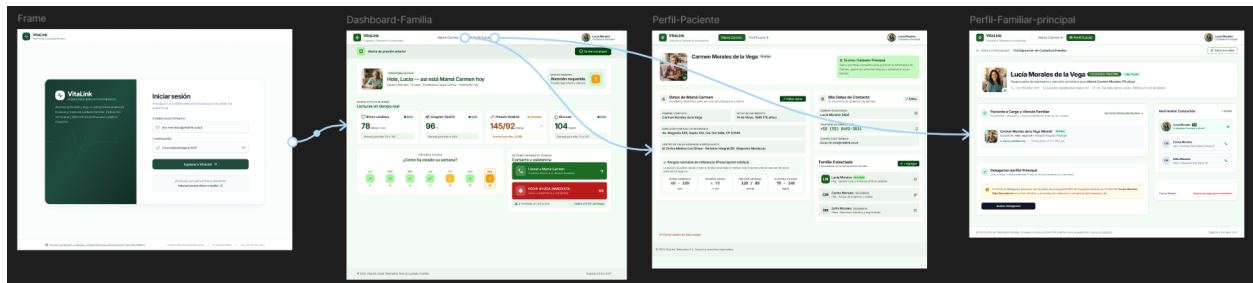


4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

Wireflow Diagrams-Vista Medico



Wireflow Diagrams-Vista Medico



4.5. Web Applications Prototyping

4.6. Domain-Driven Software Architecture

4.6.1. Design-Level Event Storming

4.6.2. Software Architecture Context Diagram

4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

4.6.4. Software Architecture Component Diagrams

4.7. Software Object-Oriented Design*

4.7.1. Class Diagrams

4.8. Database Design

4.8.1. Database Diagrams

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

5.1.1. Software Development Environment Configuration

5.1.2. Source Code Management

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

5.1.4. Software Deployment Configuration

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.3. Sprint 3

5.2.3.1. Sprint Planning 3

5.2.3.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.3.3. Sprint Backlog 3

5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.3.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.4. Sprint 4

5.2.4.1. Sprint Planning 4

5.2.4.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.4.3. Sprint Backlog 4

5.2.4.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.4.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.4.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.4.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.4.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.3. Validation Interviews.

5.3.1. Diseño de Entrevistas.

5.3.2. Registro de Entrevistas.

5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.

5.4. Video About the product

6. Conclusiones

6.1 Conclusiones y recomendaciones

6.2. Video about the team

7. Bibliografia

Organización Mundial de la Salud. (2025, 1 de octubre). <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>

8. Anexos